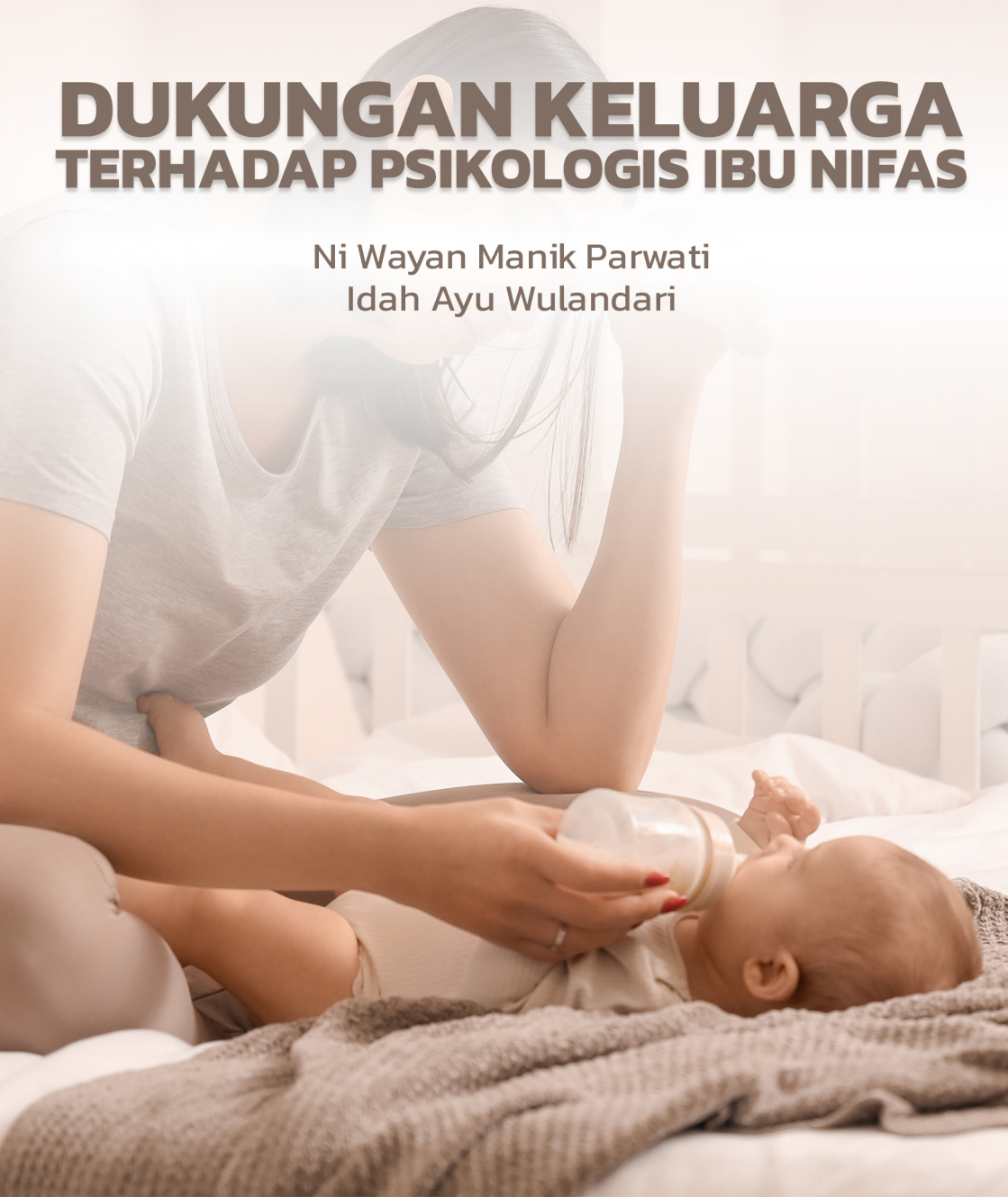


DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PSIKOLOGIS IBU NIFAS

Ni Wayan Manik Parwati
Idah Ayu Wulandari



DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PSIKOLOGIS IBU NIFAS

Penulis:

Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T., M.Keb.

Bdn. Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Dukungan Keluarga Terhadap Psikologis Ibu Nifas

Penulis: Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T., M.Keb.
Bdn. Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7097-96-5

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berjudul **Dukungan Keluarga Terhadap Psikologis Ibu Nifas** disusun sebagai bentuk upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan psikologis yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, serta berbagai faktor yang memengaruhi kondisi mental dan emosional mereka selama masa nifas.

Proses melahirkan merupakan momen penting dalam kehidupan seorang perempuan, namun seringkali diikuti oleh perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Selain menjalani proses pemulihan fisik setelah melahirkan, ibu juga dihadapkan dengan berbagai tantangan psikologis yang bisa memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Di tengah kebahagiaan menyambut buah hati yang baru lahir, banyak ibu yang juga menghadapi berbagai tekanan psikologis, mulai dari perubahan hormon, stres, kecemasan, hingga potensi depresi pasca melahirkan. Berbagai masalah psikologis seperti baby blues, depresi pascamelahirkan, serta perasaan cemas dan lelah yang mendalam, sering kali muncul selama masa ini. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kondisi psikologis ibu nifas, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi para tenaga medis, konselor, dan siapa pun yang terlibat dalam mendampingi ibu selama periode yang sangat penting ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna dan memberi manfaat tidak hanya bagi para tenaga kesehatan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan mental ibu pasca persalinan. Dengan

adanya pemahaman yang lebih baik tentang psikologi ibu nifas, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan empatik bagi ibu-ibu yang sedang melalui proses pemulihan ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih luas serta menyentuh banyak hati.

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
--------------	-----

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 MASA NIFAS.....	7
------------------------------	----------

A. Pengertian Masa Nifas.....	7
B. Perubahan Psikologis Masa Nifas	7
C. Adaptasi Psikologis	9
1. <i>Taking-In</i> (Menerima).....	13
2. <i>Taking-Hold</i> (Mengambil Alih)	14
3. <i>Letting-Go</i> (Melepaskan)	14

BAB 3 GANGGUAN PSIKOLOGIS MASA NIFAS	17
---	-----------

A. Postpartum Blues.....	17
1. Epidemiologi postpartum blues.....	18
2. Gejala postpartum Blues	21
3. Risiko Postpartum Blues.....	22
4. Patogenesis dan Patologi Postpartum Blues	22
5. Dampak Postpartum blues.....	25
B. Depresi Postpartum	26
1. Faktor-faktor Penyebab Depresi Postpartum Pada masa nifas.....	28
2. Gejala depresi postpartum.....	32
3. Dampak Depresi Postpartum	32
4. Cara Mengatasi Depresi Postpartum	33
C. Psikosis	34

D. Perbedaan Postpartum Blues, Depresi Postpartum dan Psikosis.....	36
E. Skrining gangguan psikologis masa nifas	38

BAB 4 DUKUNGAN KELUARGA PADA IBU NIFAS 45

A. Faktor-faktor yang Memengaruhi Dukungan Suami/Keluarga	47
B. Peran Suami dalam Mencegah Postpartum Blues Pada Ibu Nifas	48
C. Dukungan Intrumental	51
D. Dukungan Emosional	52
E. Dukungan Informasi	54
F. Dukungan penilaian atau penghargaan	54
G. Dukungan Suami saat Persalinan	54

BAB 5 PENUTUP..... 57

DAFTAR PUSTAKA..... 61

GLOSARIUM 67

PROFIL PENULIS 77

BAB 1

PENDAHULUAN

Masa nifas adalah periode penyesuaian yang sangat penting bagi seorang perempuan setelah melahirkan, berlangsung dari hari pertama setelah persalinan hingga kira-kira enam minggu (Juliastuti et al., 2021). Dalam fase ini, tubuh ibu nifas mengalami beragam perubahan fisik, seperti penyembuhan jaringan pascapersalinan, perubahan bentuk fisik, serta pemulihan rahim ke ukuran semula. Selain perubahan fisik, terdapat perubahan hormon yang sangat signifikan, seperti penurunan tajam hormon estrogen dan progesteron yang selama kehamilan berada dalam kadar tinggi. Perubahan hormonal ini berdampak langsung pada emosi dan suasana hati ibu, sehingga banyak ibu merasakan fluktuasi emosional, merasa lelah, dan terkadang menghadapi kesulitan beradaptasi dengan perubahan hidup yang baru. Perubahan-perubahan ini akan berdampak negatif jika ibu nifas tidak mendapatkan dukungan yang berakibat pada gangguan psikologis.

Gangguan psikologis pascapersalinan menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius yang memengaruhi banyak wanita di seluruh dunia. Masa nifas, yang biasanya dipahami sebagai tahun pertama setelah melahirkan, adalah periode yang sangat sulit secara fisik, dengan adanya perubahan hormonal dan psikologis pada ibu yang baru. Meskipun banyak wanita merasakan beragam emosi, beberapa mungkin mengalami perubahan suasana hati yang lebih berat dan terus-menerus, seperti depresi pascapersalinan, kecemasan, dan psikosis. Gangguan mood pascapersalinan merujuk pada spektrum kondisi kesehatan mental yang dapat muncul setelah

melahirkan. Depresi pascapersalinan adalah jenis gangguan suasana hati yang paling umum. Gangguan ini ditandai oleh kesedihan yang berkepanjangan, perasaan tidak berharga, serta hilangnya minat atau kebahagiaan dalam kegiatan sehari-hari. Kecemasan pascapersalinan melibatkan kekhawatiran yang berlebihan, ketegangan, dan pikiran yang mengganggu. Psikosis pascapersalinan adalah suatu kondisi yang langka tetapi serius yang ditandai dengan halusinasi, delusi, serta pemikiran yang tidak teratur. Gangguan mood pasca melahirkan memiliki dampak luas bagi ibu dan keluarganya. Mereka dapat berdampak signifikan pada kemampuan ibu dalam merawat dirinya dan bayinya, mengganggu ikatan antara ibu dan bayi, serta mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan unit keluarga. Selain itu, gangguan mood pasca melahirkan yang tidak mendapatkan perawatan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental ibu, dengan kemungkinan implikasi pada kehamilan dan pengasuhan di masa mendatang (Garapati et al. , 2023).

Gangguan psikologis pasca salin menimbulkan tantangan besar bagi kesehatan mental dan kesejahteraan wanita selama periode pasca melahirkan. Tinjauan ini memberikan wawasan mengenai diagnosis, pencegahan, dan pengobatan untuk gangguan ini. serta mengupas klasifikasi dan jenis-jenis gangguan mood pascapersalinan, dengan penekanan pada perlunya diagnosis dan diferensiasi yang tepat. Prevalensi dan tingkat kejadian dieksplorasi untuk menyoroti ruang lingkup serta dampak dari gangguan ini. Tinjauan ini meneliti berbagai faktor risiko yang berkaitan dengan gangguan mood pasca melahirkan, termasuk faktor fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Memahami semua faktor risiko ini berfungsi untuk mengidentifikasi populasi yang berisiko tinggi dan memberikan panduan untuk intervensi yang tertarget. Skrining

dan diagnosis gangguan mood pascapersalinan sangat penting untuk deteksi serta intervensi yang cepat. Strategi pencegahan dieksplorasi, termasuk pendidikan antenatal, program dukungan psikososial, dan peranan profesional kesehatan dalam mempromosikan tindakan pencegahan. Intervensi pencegahan yang efektif dan hasil yang dicapai dibahas untuk membimbing penyedia layanan kesehatan dan pembuat kebijakan dalam menerapkan strategi berbasis bukti (Garapati et al., 2023).

Ibu yang mengalami depresi baik pada antepartum maupun postpartum tidak hanya berisiko tinggi terhadap bunuh diri, tetapi juga berakibat buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya karena kurangnya perhatian dari ibunya (WHO, 2018). Perubahan suasana hati ibu yang berlanjut dengan terjadinya kecemasan yang sering kita sebut sebagai postpartum blues, awalnya dianggap sebagai hal yang biasa atau normal, namun jika hal ini berlanjut maka akan berakibat depresi (Parwati et al., 2022). Perubahan suasana hati pada ibu yang mengalami postpartum blues tidak hanya terjadi pada masa nifas, namun bisa juga dari masa kehamilan (Manning, 2011). Pada masa nifas, terutama 28 hari pasca melahirkan adalah masa yang paling kritis, ibu akan dihadapkan dengan peran baru serta perubahan-perubahan lainnya yang tentunya membutuhkan adaptasi. Jika ibu tidak mampu melewati fase itu, maka ibu berisiko mengalami depresi tiga kali lipat (Cox, Murray, dan Chapman, 1993).

Prevalensi postpartum blues bervariasi di berbagai negara. Di Tanzania, hampir 8 dari 10 ibu nifas mengalami postpartum blues, sedangkan di Jepang, angka ini jauh lebih rendah, yaitu 8%. Perbedaan angka ini disebabkan oleh ketidakseragaman dalam menentukan diagnosis dan metode penelitian yang digunakan pada tiap studi. Begitu pula dengan

angka kejadian depresi postpartum yang ditemukan beragam di berbagai negara. Tingkat depresi pascapersalinan di Asia sangat bervariasi, yaitu 3,5%-63,3%, dimana negara Malaysia dengan prevalensi terendah dan Pakistan mencatat angka tertinggi. Sementara itu, di Indonesia, 50% kejadian postpartum blues pada ibu nifas terjadi dalam waktu 4-5 hari setelah melahirkan. Postpartum blues dialami ibu nifas dimana perubahan psikologis ini bersifat sementara dan pada umumnya terjadi pada minggu pertama setelah kelahiran. Sedangkan prevalensi depresi postpartum adalah 34% dan 1% yang mengalami psikosis postpartum (Yankes, 2023).

Berdasarkan data WHO tahun 2018 ditemukan sekitar 10% dari ibu yang sedang hamil dan 13% dari ibu nifas mengalami masalah kesehatan mental, terutama depresi. Sedangkan di negara-negara berkembang, angka gangguan psikologis ini ditemukan lebih tinggi, yaitu 15,6% pada masa sebelum melahirkan dan 19,8% setelah melahirkan (WHO, 2018). Penting untuk memperhatikan masalah depresi yang bisa muncul mulai dari sebelum hingga setelah melahirkan karena berakibat pada kematian ibu, seperti tindakan bunuh diri, abai terhadap bayi, bahkan menyakiti bayinya (Ohara, Okada, Kubota, dkk., 2017; Shiow-Meei Tsai, 2005; WHO, 2018).

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko masalah psikologis pada masa nifas sangat bervariasi. Faktor biologis seperti perubahan hormonal, riwayat kesehatan mental sebelumnya, serta adanya riwayat keluarga dengan gangguan psikologis memiliki peranan yang penting. Selain itu, faktor sosial, termasuk kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga, tekanan finansial, dan keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan mental, juga dapat memperburuk keadaan psikologis ibu. Stres yang diakibatkan oleh tuntutan sosial untuk menjadi ibu yang "sempurna" serta tantangan

dalam merawat bayi yang mungkin memiliki kebutuhan khusus dapat meningkatkan masalah psikologis pada perempuan di masa nifas ini.

Suami merupakan individu yang sangat penting dalam kehidupan seorang istri terutama ibu hamil. Kehadiran suami dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikis saat istrinya hamil hingga pasca melahirkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental ibu. Persepsi positif suami terhadap peran barunya, terutama pada ibu yang baru pertama kali menjadi seorang ibu, dapat meningkatkan keyakinan ibu akan kemampuan yang dimilikinya, sehingga memberikan rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Kontribusi pasangan atau suami dalam memfasilitasi tekanan emosional ibu merupakan dukungan instrumental yang sangat berpengaruh bagi ibu nifas. Seorang suami yang mampu mendengarkan keluhan yang dirasakan ibu dan memberikan kasih sayang dapat mengurangi stres yang dialami seorang ibu dari awal masa kehamilan sampai persalinan. Pendekatan emosional dengan pasangan, saling berbagi emosi, kepedulian, dan ungkapan penghargaan atas kemampuannya dalam mengasuh anak serta kemampuannya untuk mengandalkan suami ketika memerlukan bantuan adalah berbagai bentuk dukungan sosial yang bisa diberikan suami kepada istrinya. Perasaan diabaikan yang dialami oleh ibu, baik dari suami maupun keluarganya, dapat mengakibatkan timbulnya stres, sehingga dukungan sangat krusial untuk diberikan (Fauziah et al. , 2022; Winarni et al. , 2018).

Penanganan masalah psikologis pada masa nifas memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan keluarga, tenaga medis, dan dukungan dari komunitas. Dukungan emosional dari pasangan dan keluarga sangat berharga, sama halnya dengan konseling psikologis yang diberikan oleh tenaga profesional. Terapi kelompok dengan

ibu-ibu lain yang memiliki pengalaman yang serupa juga dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi psikologis ibu karena memberikan rasa kebersamaan dan dukungan sosial. Di sisi yang lain, pendidikan tentang kesehatan mental dan pemahaman bahwa masalah psikologis pascapersalinan adalah hal yang umum dapat membantu ibu dan keluarga untuk lebih siap melewati masa nifas dengan lebih baik.

Dengan adanya perhatian dari keluarga dan penanganan yang tepat, kondisi perubahan dan adaptasi psikologis yang dialami oleh ibu selama postpartum dapat diatasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ibu, bayi, dan keharmonisan dalam keluarga.

BAB 2

MASA NIFAS

A. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode postpartum di mana tubuh ibu mengalami proses perubahan dan adaptasi secara fisiologis maupun psikologis pasca persalinan. Masa nifas juga disebut sebagai “puerperium”. Masa nifas sudah dimulai setelah lahirnya plasenta dan umumnya berlangsung selama 6-8 minggu atau sekitar 40 hari. Namun ditemukan beberapa kasus, masa nifas bisa berlangsung lebih lama (Sumiaty, 2018; Wahyuningsih, 2018)

Masa nifas yang lebih panjang ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti komplikasi/penyulit saat persalinan, infeksi, atau kondisi kesehatan tertentu yang memperlambat pemulihan tubuh ibu. Selama masa ini, alat reproduksi ibu masih mengeluarkan lochea, yang merupakan sisa-sisa plasenta dan lapisan rahim. Pengeluaran lochea biasanya berkurang dari waktu ke waktu, tapi pada masa nifas yang lebih panjang, pengeluaran ini bisa berlangsung lebih lama atau muncul kembali setelah sempat berhenti (Kemenkes RI, 2019).

B. Perubahan Psikologis Masa Nifas

Pada periode nifas ini, seorang ibu pasca salin tidak hanya mengalami perubahan fisik namun juga mengalami perubahan emosional dan psikologis. Faktor-faktor yang

memengaruhi psikologis ibu nifas sering bersifat kompleks. Faktor hormonal, sosial, dan lingkungan sering diduga sebagai penyebab perubahan tersebut. Memahami perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami ibu nifas sangat penting dilakukan oleh keluarga khususnya suami/pasangan untuk mencegah dampak negatif seperti postpartum blues bahkan postpartum depression (Cunningham et al., 2017; Juliastuti et al., 2021).

Secara psikologis, masa nifas bisa menjadi waktu yang penuh tantangan. Salah satu masalah psikologis paling umum yang dialami adalah "baby blues atau postpartum blues," yang terjadi pada sekitar 70–80% ibu baru. Baby blues dicirikan oleh gejala seperti perasaan sedih, mudah menangis, cemas, dan perubahan suasana hati yang cepat. Meskipun keluhan ini umumnya berlangsung hanya beberapa hari atau minggu pertama setelah melahirkan, namun kondisi ini dapat berubah menjadi masalah yang vital, yaitu depresi postpartum, yang membutuhkan perhatian medis dan dukungan emosional yang lebih mendalam. Depresi postpartum pada umumnya terlihat dalam beberapa minggu atau bulan setelah melahirkan dan ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, putus asa, kelelahan ekstrem, kecemasan berlebihan, serta kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai (Lindayani & Marhaeni, 2019; Rezaie-Keikhaie et al., 2020)

Selain itu, beberapa ibu mengalami kecemasan berlebihan terkait kesehatan bayi atau ketidakmampuan dalam merawat anak, yang sering kali disebut dengan istilah gangguan kecemasan postpartum. Kecemasan ini dapat membuat ibu merasa takut atau tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu, hingga merasa tertekan

dengan tanggung jawab baru. Ibu yang mengalami kecemasan atau depresi pascapersalinan mungkin menemukan kesulitan dalam membangun ikatan emosional dengan bayi mereka. Ini, jika tidak segera diatasi, dapat mempengaruhi perkembangan emosional bayi dalam jangka panjang, mengingat kedekatan antara ibu dan bayi merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan anak yang sehat (Herliawati et al., n.d.)

C. Adaptasi Psikologis

Adaptasi psikologis selama masa nifas adalah proses penting yang dialami ibu setelah melahirkan. Pada fase ini ibu nifas akan menyesuaikan diri baik secara fisik maupun psikologis yang terjadi dalam kehidupan mereka. Masa ini penuh dengan tantangan fisik dan emosional, karena ibu menghadapi perubahan besar dalam tubuh, rutinitas, serta peran baru sebagai pengasuh utama bayi. Adaptasi psikologis yang sehat sangat penting, karena dapat membantu ibu mengelola tekanan dan kecemasan, memperlambat ikatan dengan bayi, serta menjaga keseimbangan emosional dan kesejahteraan jangka panjang.

Mc Grandles & Duffy (2012) mengemukakan bahwa *bounding* antara seorang ibu dan anaknya merupakan karakteristik yang berkembang secara alami melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Proses ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seorang wanita. Keberhasilan dalam menjaga hubungan antara seorang ibu sebagai pengasuh dan anaknya berdampak positif sepanjang hidup terhadap perkembangan psikologis anak dan peran orang tua (Meighan, 2014).

Beberapa aspek utama dalam adaptasi psikologis pada masa nifas meliputi: (Garapati et al., 2023; Oktaputrining et al., 2017; Pius Kamsu Moyo, 2020; Purwati & Kustiningsih, 2018; Rini & Kumala, 2016; Winingsih et al., 2021)

1. Keadaan psikologis menjadi seorang ibu
Seorang perempuan membutuhkan suatu pengakuan pada dirinya yang akan mempunyai peran baru sebagai seorang ibu saat pertama kali dinyatakan hamil.
2. Penyesuaian terhadap Peran sebagai Ibu
Setelah melahirkan, ibu dihadapkan pada peran baru yang menuntut tanggung jawab besar. Banyak ibu mengalami perubahan identitas sebagai "ibu" yang berbeda dari peran sebelumnya. Penyesuaian ini memerlukan waktu, karena mereka harus belajar merawat bayi, memahami kebutuhan bayi, dan menerima tanggung jawab baru. Tidak jarang ibu merasa cemas, ragu, atau khawatir tentang kemampuan mereka untuk menjalankan peran ini dengan baik, terutama bagi ibu baru.
3. Mengelola Perubahan Emosional
Fluktuasi hormon setelah persalinan, terutama penurunan hormon estrogen dan progesteron, sering memengaruhi suasana hati. Hal ini dapat menyebabkan ibu merasa sedih, mudah marah, atau cemas dalam beberapa minggu pertama setelah melahirkan. Kondisi ini dikenal sebagai "baby blues." Selain itu, beberapa ibu mungkin mengalami perasaan putus asa atau bahkan depresi postpartum, yang lebih serius dan membutuhkan dukungan tambahan. Penting bagi ibu untuk menyadari bahwa perubahan suasana hati ini adalah bagian normal dari adaptasi dan

tidak perlu merasa malu atau merasa bersalah atas emosi mereka.

4. Membangun Ikatan Emosional dengan Bayi

Ikatan antara ibu dan bayi biasanya terbentuk secara bertahap. Hubungan ini sangat penting untuk perkembangan emosional bayi dan juga untuk kesejahteraan psikologis ibu. Sebagian ibu merasakan ikatan langsung begitu bayi lahir, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan ikatan tersebut. Merawat bayi, sentuhan fisik, dan interaksi yang penuh kasih sayang adalah cara yang membantu memperkuat ikatan ini. Proses ini juga membantu ibu merasa lebih nyaman dan terhubung secara emosional dengan bayi.

5. Menerima Perubahan dalam Hubungan dengan Pasangan dan Lingkungan Sosial

Kelahiran bayi dapat mengubah dinamika dalam hubungan ibu dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman. Waktu yang lebih sedikit dengan pasangan atau teman, serta perhatian yang lebih banyak pada bayi, kadang menimbulkan rasa isolasi atau bahkan konflik. Dukungan dari pasangan dan lingkungan sosial sangat penting agar ibu dapat menyesuaikan diri dan tidak merasa sendirian dalam menjalani peran baru ini. Komunikasi yang terbuka dengan pasangan serta dukungan dari teman atau keluarga dapat membantu ibu merasa lebih percaya diri dan didukung.

6. Mengelola Kecemasan dan Ketidakpastian

Kecemasan tentang kesehatan bayi, perkembangan bayi, atau bahkan kemampuan diri sendiri untuk merawat bayi adalah perasaan yang umum pada masa nifas. Banyak ibu merasa khawatir jika mereka

melakukan kesalahan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi mereka. Adaptasi psikologis yang sehat melibatkan penerimaan bahwa perasaan cemas dan ketidakpastian adalah hal yang wajar. Memiliki akses ke informasi yang akurat tentang perawatan bayi, bergabung dengan komunitas ibu lainnya, dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan bisa membantu ibu mengelola rasa cemas ini.

7. Merawat Diri Sendiri

Merawat diri adalah bagian penting dari adaptasi psikologis, tetapi sering kali diabaikan karena ibu fokus merawat bayi. Kelelahan fisik dan kurang tidur selama masa nifas dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosi. Memprioritaskan waktu untuk istirahat, menerima bantuan dari orang lain, serta menjaga pola makan dan kesehatan fisik bisa membantu ibu menjaga kesehatan mental mereka. Merawat diri juga memberikan ibu waktu untuk pulih dan merasa lebih siap dalam menjalani peran sebagai ibu.

8. Mengakses Dukungan Psikologis

Beberapa ibu mungkin menemukan adaptasi psikologis pasca-persalinan ini lebih sulit dari yang lain, terutama jika mereka mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi postpartum atau gangguan kecemasan. Dalam kasus ini, mengakses dukungan psikologis, seperti konseling, terapi, atau bimbingan dari profesional, sangat penting. Terapi dapat membantu ibu memahami emosi mereka, mengatasi tekanan, dan memberikan strategi untuk menyesuaikan diri dengan peran sebagai ibu.

Adaptasi psikologis pada masa nifas merupakan proses bertahap dan individual bagi setiap ibu. Dengan dukungan yang memadai, pengetahuan yang cukup, serta perhatian pada kesehatan mental, ibu dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik, merasa lebih siap, dan menikmati peran baru mereka sebagai ibu. Reva Rubin, seorang perawat dan peneliti di bidang kesehatan maternal, mengembangkan teori adaptasi psikologis untuk ibu pascapersalinan yang menjelaskan tahapan psikologis yang dilalui ibu setelah melahirkan. Rubin mengidentifikasi tiga fase penting yang dialami oleh ibu dalam proses penyesuaian peran sebagai ibu. Teori adaptasi psikologis Reva Rubin menekankan bahwa proses penyesuaian psikologis seorang ibu pascapersalinan memerlukan waktu dan dukungan. Setiap fase adalah bagian penting dari perkembangan psikologis ibu, di mana kebutuhan emosional ibu dan dukungan lingkungan sangat berperan. Teori ini juga menunjukkan bahwa proses adaptasi menjadi ibu bukanlah sesuatu yang instan, tetapi membutuhkan penyesuaian bertahap yang berpusat pada penerimaan peran baru, peningkatan keterampilan mengasuh, dan penyatuan identitas sebagai seorang ibu. Teori ini telah digunakan secara luas dalam praktik keperawatan untuk memahami kebutuhan ibu pascapersalinan, memberikan dukungan yang sesuai dengan fase yang sedang dijalani ibu, serta mengurangi risiko masalah psikologis seperti depresi postpartum.

1. *Taking-In* (Menerima)

Tahap ini umumnya terjadi pada 3 hari pertama setelah kelahiran bayinya. Pada tahap ini, ibu cenderung lebih fokus pada dirinya sendiri dan pengalamannya selama persalinan. Ibu sering kali

merasa lelah secara fisik dan emosional setelah melahirkan, sehingga lebih membutuhkan waktu untuk beristirahat, memproses pengalaman persalinan, dan menerima kenyataan bahwa mereka kini adalah seorang ibu. Ibu cenderung pasif pada tahap ini, lebih banyak berbicara tentang proses persalinan dan meminta perhatian serta dukungan dari orang di sekitarnya, terutama dari pasangan dan keluarga. Pada tahap ini, ibu mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengambil alih perawatan bayi secara mandiri karena lebih banyak berfokus pada pemulihan diri.

2. *Taking-Hold* (Mengambil Alih)

Fase ini berlangsung antara hari ke-2 hingga beberapa minggu setelah melahirkan, tergantung pada kesiapan ibu. Pada tahap ini, ibu mulai lebih aktif dalam perawatan bayi dan menunjukkan minat untuk belajar bagaimana merawat bayi secara langsung. Ia mulai mengembangkan kepercayaan diri dalam menjalankan perannya sebagai ibu dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Meskipun demikian, ibu sering kali merasa ragu terhadap kemampuannya dan membutuhkan dukungan serta bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman atau tenaga medis. Fase "taking-hold" dianggap sebagai periode kritis di mana dukungan dari keluarga, teman, atau petugas kesehatan sangat penting untuk membantu ibu merasa lebih yakin dan nyaman dalam mengasuh bayinya.

3. *Letting-Go* (Melepaskan)

Fase ini adalah tahap terakhir dari adaptasi psikologis menurut Rubin dan dapat berlangsung hingga beberapa bulan setelah kelahiran. Pada tahap

ini, ibu mulai menerima dan menyesuaikan diri sepenuhnya dengan peran baru sebagai seorang ibu. Ibu belajar untuk melepaskan harapan yang ideal dan menerima kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ia mulai menyeimbangkan peran barunya dengan tanggung jawab lain, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah, seperti pekerjaan atau kehidupan sosialnya. Pada tahap ini, ibu juga cenderung untuk lebih menerima bantuan dari orang lain dan membangun dukungan sosial, serta lebih terbuka terhadap kebutuhan bayinya. Fase "letting-go" ini menandai bahwa ibu telah mencapai keseimbangan antara identitas lamanya dan identitas baru sebagai seorang ibu.

BAB 3

GANGGUAN PSIKOLOGIS MASA NIFAS

A. Postpartum Blues

Postpartum Blues adalah kondisi emosional yang ditandai oleh timbulnya perasaan sedih dan murung pada wanita pasca melahirkan, umumnya bersifat sementara selama 2-14 hari setelah kelahiran anak. Kondisi ini termasuk dalam kategori gangguan afek ringan yang sering terjadi dalam minggu pertama pasca persalinan, seringkali terabaikan, tidak terdiagnosis, dan akhirnya tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Postpartum Blues terjadi saat seorang ibu kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup yang terjadi akibat kehamilan, proses persalinan, dan masa pasca melahirkan (Ernawati, Merlin, dan Ismarwati, 2020).

Postpartum Blues mencerminkan situasi di mana seorang ibu baru mengalami gangguan psikologis ringan karena kesulitan beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu, biasanya terjadi dalam rentang waktu 14 hari hingga 1 bulan setelah persalinan, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dukungan keluarga. Jika Postpartum Blues tidak membaik dalam dua minggu, risiko munculnya postpartum depression dan postpartum psychosis akan meningkat (Ernawati, Merlin, dan Ismarwati, 2020; Pius Kamsu Moyo, 2020).

1. Epidemiologi postpartum blues

Postpartum blues sering dialami oleh perempuan yang menikah pada usia muda. Indonesia menempati posisi ke-37 dalam peringkat negara dengan persentase pernikahan usia muda tertinggi di dunia, dan menduduki peringkat kedua di ASEAN setelah Kamboja (Istiani, 2016). Di Asia, angka kejadian postpartum blues bervariasi antara 26 hingga 85%, sementara di Indonesia, prevalensi postpartum blues berkisar antara 50 hingga 70% pada wanita setelah melahirkan (Putri, 2019). Meskipun postpartum blues merupakan kondisi umum yang memengaruhi sekitar 50-80% dari ibu baru menurut sebagian besar sumber (Bobo, 2014), perkiraan prevalensinya sangat beragam dalam literatur, berkisar antara 26 hingga 85%, bergantung pada kriteria yang digunakan (Howard, 2017; Ohara, 2014; Seyfried, 2003; MGH Center for Women's Mental Health, 2019).

Sulit untuk mendapatkan angka yang pasti mengingat kurangnya kriteria diagnostik yang standar, variasi dalam presentasi gejala untuk perawatan medis, dan keterbatasan metodologis dalam pelaporan retrospektif gejala. Meskipun bukti menunjukkan bahwa postpartum blues ditemukan di berbagai negara dan budaya, terdapat keragaman yang signifikan dalam tingkat prevalensi yang dilaporkan. Sebagai contoh, prevalensi postpartum blues dalam literatur berkisar dari 15% di Jepang (Watanabe et al., 2008) hingga 60% di Iran (Akbarzadeh et al., 2015). Salah satu penjelasan atas heterogenitas ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pelaporan gejala akibat norma budaya dan harapan sosial yang ada.

Postpartum blues dilaporkan mempengaruhi 50-80% wanita setelah melahirkan (O'Hara & McCabe, 2013). Kondisi ini biasanya muncul pada hari kedua hingga keempat postpartum dan mencapai puncaknya dalam seminggu pertama. Sebagian besar gejala mereda dalam dua minggu (Lindayani & Marhaeni, 2019; Rezaie-Keikhaie et al., 2020)

Epidemiologi postpartum blues menunjukkan bahwa kondisi ini tidak terbatas pada ras, etnis, atau budaya tertentu. Namun, tingkat keparahan dan durasi gejala dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, dan budaya yang mendukung kesejahteraan ibu (Đuričeková et al., 2024; Negrón et al., 2013)

Beberapa studi menunjukkan bahwa prevalensi postpartum blues lebih tinggi pada populasi dengan tingkat stres yang tinggi, seperti ibu yang melahirkan dengan komplikasi medis atau yang tinggal di lingkungan dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental. Selain itu, hubungan antara postpartum blues dan kehadiran dukungan sosial juga menjadi fokus penelitian. Ibu yang merasa didukung oleh pasangan, keluarga, atau kelompok komunitas cenderung melaporkan gejala yang lebih ringan dan lebih cepat pulih dibandingkan mereka yang merasa terisolasi

Faktor demografi, seperti usia ibu, paritas (jumlah kelahiran sebelumnya), dan status pekerjaan, juga memengaruhi prevalensi postpartum blues. Ibu yang lebih muda atau ibu primipara (melahirkan anak pertama) dilaporkan lebih rentan mengalami postpartum blues dibandingkan ibu multipara.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ibu yang bekerja cenderung memiliki risiko lebih rendah, karena kemungkinan adanya jaringan sosial yang lebih baik di luar rumah.

Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab dari postpartum blues, yaitu:

a. Faktor Biologis (Perubahan Hormon dan Genetika)

Perubahan hormonal: Masa nifas ditandai dengan adanya perubahan hormonal yang signifikan, termasuk penurunan cepat kadar estrogen dan progesteron. Fluktuasi hormonal ini diyakini berdampak signifikan dalam mengembangkan gangguan mood pasca melahirkan. Estrogen dan progesteron telah diketahui mempunyai efek pada sistem neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, yang mengatur suasana hati. Penurunan kadar hormon yang terjadi secara tiba-tiba setelah melahirkan dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter ini, berpotensi berkontribusi terhadap timbulnya depresi pasca melahirkan, kecemasan, atau gangguan mood lainnya. Namun, Mekanisme pasti bagaimana perubahan hormonal mempengaruhi suasana hati selama periode pascapersalinan belum diketahui dipahami sepenuhnya dan terus menjadi subjek penelitian yang sedang berlangsung.

b. Predisposisi genetik: Bukti yang muncul menunjukkan adanya kecenderungan genetik terhadap gangguan mood pascapersalinan. Wanita dengan riwayat keluarga yang mengalami depresi atau gangguan mood lainnya mungkin memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap depresi mengalami depresi atau

kecemasan pasca melahirkan. Penelitian telah mengidentifikasi gen spesifik dan variasi genetik dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya gangguan ini. Faktor genetik berinteraksi dengan lingkungan dan pengaruh hormonal, berkontribusi terhadap interaksi kompleks antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suasana hati pascapersalinan gangguan. Memahami dasar genetik kelainan ini dapat membantu mengidentifikasi individu yang berisiko lebih tinggi dan mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan yang ditargetkan

2. Gejala postpartum Blues

Gejala khas postpartum blues mencakup perubahan suasana hati yang labil, muncul rasa sedih, sensitive, mudah tersinggung, mudah marah, kecemasan, gangguan tidur dalam dua minggu pasca melahirkan, sering menangis tanpa alasan yang jelas, ketidaksabaran, rasa gelisah, mudah lelah, dan penurunan konsentrasi (Gale & Harlow, 2003; Zager, 2009). Dampak dari perubahan ini dapat dirasakan dalam interaksi keluarga serta pengasuhan terhadap bayi yang baru lahir (Pillitteri, 2009). Meskipun gejala ini mungkin pulih dengan sendirinya tanpa faktor risiko tambahan, penting untuk memantau secara ketat ibu yang memiliki riwayat depresi berat, karena gejala postpartum blues dapat menjadi petunjuk awal bahwa depresi akan kambuh (Luskin, Pundiak, & Habib, 2007).

Gejala postpartum blues umumnya mulai berkurang dan menghilang dalam waktu empat belas hari setelah melahirkan dengan adanya beberapa intervensi. Namun, jika terdapat faktor risiko tertentu,

kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi (Stewart et al., 2003).

3. Risiko Postpartum Blues

Risiko terjadinya postpartum blues akan meningkat jika ditemukan ibu yang memiliki kondisi-kondisi yaitu:

- a. Ibu nifas yang terpapar stressor atau yang pernah mengalami gangguan kecemasan baik saat hamil, bersalin maupun masa nifas.
- b. Hamil yang tidak direncanakan (KTD)
- c. Keadaan bayi yang lahir dengan kelainan kongenital atau memerlukan perawatan intensif pasca melahirkan
- d. Melahirkan di usia muda yaitu kurang dari 20 tahun, yang berhubungan dengan kesiapan fisik dan mental menjadi ibu
- e. Lingkungan sosial disekitar ibu seperti suami, keluarga dan teman yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, komunikasi yang tidak baik dan kurangnya dukungan kepada ibu nifas.
- f. Adanya masalah sosial ekonomi terkait biaya perawatan bayi
- g. Ibu yang dimasa kecilnya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungannya sehingga muncul rasa kurang dihargai sebagai perempuan

4. Patogenesis dan Patologi Postpartum Blues

Postpartum blues merupakan kondisi yang memicu gangguan afektif dan perubahan mood yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan psikososial (Robertson, Celasun, Donna, & Stewart, 2008). Sejak masa kehamilan hingga kelahiran bayi, faktor-faktor

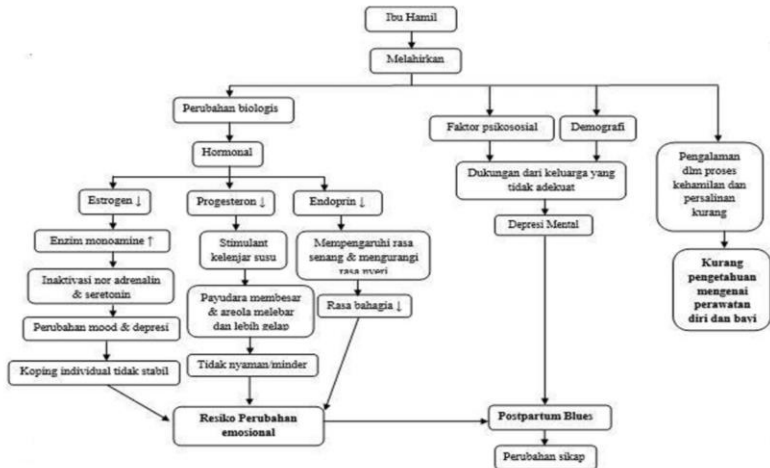
tersebut mengalami perubahan secara bersamaan. Proses adaptasi terhadap perubahan fisik dan penerimaan terhadap kehamilan dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mengelilingi ibu. Lingkungan sosial memiliki harapan bahwa ibu dapat menerima dan melaksanakan peran barunya sebagai seorang ibu. Namun, beberapa faktor dapat menyebabkan ibu mengalami perubahan emosional yang menghambat proses penyesuaian dirinya sebagai seorang ibu, seperti kelelahan karena terjaga di malam hari untuk merawat bayi, kurang tidur, gangguan aktivitas, frekuensi menyusui, nyeri persalinan, dan faktor-faktor lainnya yang merupakan prediktor postpartum blues, seperti riwayat depresi baik dalam keluarga maupun pada ibu, penyesuaian sosial, peristiwa kehidupan yang menimbulkan stres, dan perubahan hormonal (O'Hara, Schlechte, Lewis, & Wright, 1991).

Menurut Bloch, Rotenberg, Koren, & Klein (2006), faktor-faktor seperti personalitas, depresi selama kehamilan, dan perubahan suasana hati saat pramenstruasi dapat memicu terjadinya postpartum blues. Faktor lain yang dapat menjadi pemicu postpartum blues meliputi status pendidikan, gaya hidup, pendapatan keluarga, paritas, kondisi obstetrik, dan kesehatan bayi (Akker, 2012; Faisal-Cury et al., 2008). Prevalensi postpartum blues cenderung lebih tinggi pada ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Gaya hidup seperti merokok, status pernikahan, dan kehamilan di luar pernikahan juga merupakan prediktor yang signifikan untuk terjadinya postpartum blues. Faktor-faktor tersebut di atas dapat menjadi sumber stres bagi ibu, yang merangsang tubuh untuk

memproduksi hormon kortisol sebagai respons terhadap stres (Barrett et al., 2002). Hormon stres yang diproduksi dapat mencetuskan gejala postpartum blues seperti perasaan sedih, murung, penarikan diri, kecemasan, dan kemarahan (Henshaw, 2000; Stewart et al., 2003). Perubahan emosional dan mood juga dapat memengaruhi interaksi ibu dengan bayi, termasuk dalam pembentukan ikatan (attachment) yang penting antara keduanya (Lubit, 2015; Pollock & Percy, 1999).

Patofisiologi postpartum blues melibatkan interaksi kompleks antara faktor hormonal, neurokimia, dan psikologis. Penurunan tajam hormon estrogen dan progesteron setelah persalinan dianggap sebagai pemicu utama (O'Hara & McCabe, 2013). Hormon-hormon ini memiliki peran penting dalam regulasi emosi dan fungsi otak. Perubahan hormonal ini dapat memengaruhi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA (gamma-aminobutyric acid), yang semuanya berperan dalam kestabilan suasana hati.

Selain itu, kadar hormon stres seperti kortisol juga mengalami fluktuasi selama periode postpartum. Kortisol yang tinggi dapat memperburuk gejala kecemasan dan iritabilitas. Faktor lain yang relevan adalah kurang tidur, yang umum terjadi pada ibu baru dan dapat memengaruhi regulasi emosi serta fungsi kognitif (Reck et al., 2009).



Gambar 3.1: Patofisiologi Postpartum blues
Sumber: Nanda, Nic Noc, 2018

5. Dampak Postpartum blues

Postpartum blues yang tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat berkembang menjadi depresi postpartum, dan jika depresi tersebut tidak membaik setelah 6 minggu dan malah semakin parah, maka kondisi ini bisa berubah menjadi psikosis postpartum. Ketika postpartum blues berlanjut menjadi depresi postpartum, tingkat kesedihan yang dirasakan oleh ibu akan meningkat secara signifikan, menyulitkan ibu dalam menjalankan perannya sebagai orang tua, dan gejala depresi dapat membawa dampak negatif yang serius bagi ibu, bayi, dan anggota keluarga lainnya (Tilana, 2021).

Gangguan kesehatan mental pasca persalinan yang dialami oleh ibu dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan bayinya. Ketidakmampuan ibu dalam merawat bayi secara optimal karena merasa

tidak berdaya atau tidak mampu bisa menyebabkan ibu menghindari tanggung jawabnya, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi kebersihan dan kesehatan bayi yang tidak optimal serta kurangnya semangat ibu dalam menyusui. Hal ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak optimal seperti bayi yang dirawat oleh ibu yang sehat. Selain itu, hubungan antara ibu dan bayi juga dapat terganggu. Bayi sangat bergantung pada interaksi dengan ibunya, yang biasanya dilakukan melalui berbagai cara seperti senyuman, tatapan mata, celoteh, tangisan, dan gerakan tubuh yang beragam. Penting bagi ibu untuk merespons interaksi ini dengan tepat dan optimal, karena ketidakmampuan dalam memberikan respon yang sesuai dapat membuat bayi merasa kecewa, sedih, bahkan frustrasi. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan optimal bayi dan mengakibatkan kepribadian bayi tidak berkembang dengan matang (Sepriani, 2020).

B. Depresi Postpartum

Depresi postpartum merupakan gangguan psikologis yang dialami ibu setelah melahirkan. Meskipun postpartum blues atau baby blues yang ringan dan berlangsung singkat sering dialami oleh banyak ibu, depresi postpartum adalah kondisi yang lebih serius dan bisa berlangsung lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Gejala depresi postpartum meliputi perasaan putus asa, kurangnya minat atau kegembiraan dalam merawat bayi, kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, serta munculnya pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri atau bayi. Depresi postpartum bukanlah tanda kelemahan atau ketidakmampuan, tetapi merupakan gangguan mood

yang kompleks yang bisa disebabkan oleh kombinasi perubahan hormonal, tekanan emosional, dan faktor sosial.

PPD adalah kondisi kesehatan mental parah yang menyerang wanita setelah melahirkan. Ini melibatkan perasaan sedih dan hampa, dan kurangnya emosi. Jika hal ini terjadi, ibu merasa tidak terhubung kepada bayinya, seolah-olah dia bukan ibunya. PPD lebih dari sekedar 'baby blues', yang hanya berlangsung beberapa hari (biasanya 2–5 hari) setelah melahirkan. PPD bisa bertahan selama 1 tahun setelah melahirkan. Menurut Kaya (2022), PPD memiliki gejala yang sama dengan baby blues; satu-satunya perbedaan adalah yang pertama berlangsung antara 2 dan 8 minggu, dan dalam beberapa kasus, hingga satu tahun. Rich menambahkan bahwa PPD juga melibatkan perasaan cemas yang intens.

PPD mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap ibu dan bayinya. Ibu yang menderita PPD mengalami kehilangan nafsu makan, menangis, tanggung jawab emosional, konsentrasi buruk, ketidakmampuan untuk mengatasinya dengan bayi, putus asa, keinginan bunuh diri, perasaan bersalah, gangguan tidur, kehilangan ingatan, mudah tersinggung kemampuan, dan kelelahan. Mughal dkk. (2022) mengatakan bahwa PPD memberikan dampak negatif terhadap fungsi normal perempuan, sehingga membuat anak-anak mereka berada dalam bahaya. Tidak aman memiliki ibu yang mentalnya tidak seimbang untuk merawat bayinya. Hal ini karena, selama pada masa bayi, anak-anak masih rentan dan rentan; oleh karena itu mereka membutuhkan perhatian dan kelembutan penuh, yang hanya mungkin terjadi dari ibu yang seimbang secara mental.

Depresi pascapersalinan adalah gangguan mood yang menyerang individu dalam waktu 1 tahun setelah

melahirkan. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), depresi pascapersalinan kini termasuk dalam istilah depresi perinatal. Episode depresi berat yang dimulai selama kehamilan atau dalam waktu 4 minggu setelah melahirkan diklasifikasikan sebagai depresi peripartum. Istilah ini mencakup depresi prenatal dan postpartum. DSM-5 tidak mengakui PPD sebagai entitas terpisah. Sebaliknya, PPD dimasukkan dalam diagnosis depresi peripartum yang lebih luas Berbeda dengan “baby blues”, yang biasanya hilang dalam beberapa minggu, PPD lebih parah dan dapat berlangsung berbulan-bulan jika tidak diobati (Carlson et al., 2024)

1. Faktor-faktor Penyebab Depresi Postpartum Pada masa nifas

Ibu yang kurang bisa beradaptasi bisa mengalami gangguan psikologis. Gangguan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi. Etiologi dari depresi postpartum tidak diketahui secara pasti akarnya dari mana, namun beberapa faktor berkontribusi sebagai penyebab depresi postpartum (Afshari et al., 2020). Adapaun beberapa faktor tersebut antara lain:

a. Faktor riwayat obstetri

Status paritas berhubungan dengan terjadinya gangguan postpartum seperti pada pengalaman obstetrinya apakah ada komplikasi yang terjadi pada kehamilan sampai persalinan sekarang maupun yang lalu dan sebagian besar adalah ibu primipara. Primipara menjadi lebih rentan terhadap gangguan tersebut karena beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan terkait perawatan diri dan bayinya. Sehingga jika dalam proses tersebut ibu tidak bisa beradaptasi, maka ibu bisa mengalami

gangguan postpartum (Pitt dalam Lailiyana & Sari, 2021).

Pengalaman persalinan memiliki pengaruh terhadap munculnya depresi postpartum pada ibu. Seperti disampaikan oleh Rosalinna dan Siswiyanti (2022) bahwa ibu yang melewati persalinan dengan komplikasi dimana onset awalnya mengalami postpartum blues kemudian menjadi depresi postpartum. Ibu dengan komplikasi parah saat periode postpartum mengalami peningkatan resiko mortalitas dan morbiditas selama setahun pertama postpartum. Pada 8 minggu dan 12 bulan dapat muncul gejala depresi seperti kesulitan menyelesaikan pekerjaan rumah dan dengan adanya masalah keuangan menjadi lebih besar. Ibu harus mendapat penanganan lebih lanjut dengan teratur baik secara fisik dan psikologisnya selama setahun masa postpartum.

Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa sebesar 36,3% jenis persalinan berpengaruh terhadap peningkatan depresi postpartum. Ibu dengan riwayat persalinan operasi berpeluang 3,716 lebih besar untuk mengalami depresi dibandingkan ibu dengan riwayat persalinan pervaginam. Dengan pengalaman persalinan sebelumnya dapat menjadi resiko timbulnya depresi postpartum (Ariyanti et al., 2016)

b. Faktor psikososial

Adapun beberapa karakteristik yang dapat memengaruhi depresi postpartum, sebagai berikut:

1) Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi depresi. Hasil penelitian dari

Oiftiyah (2018) bahwa adanya keterkaitan umur ibu dengan kejadian postpartum blues. Seperti yang kita ketahui, awal dari gangguan psikologis ibu mulai dari postpartum blues yang mana apabila tidak tertangani dengan baik, maka ibu bisa mengalami depresi postpartum. Faktor umur perempuan ini selalu dikaitkan dengan kesiapan ibu terkait peran barunya. Usia responden yang mengalami postpartum blues justru pada usia aman untuk reproduksi berkisar usia 20-35 tahun (Qiftiyah, 2018).

2) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi pengetahuan ibu terhadap sesuatu sehingga dapat mengakibatkan munculnya persepsi dan sikap yang negatif berhubungan dengan situasi yang tidak menguntungkan (Fatmawati, 2015).

3) Pekerjaan

Pekerjaan bisa berpengaruh terhadap depresi postpartum. Pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat depresi dari ibu karena berkaitan dengan urusan rumah tangga dan beban yang ditanggung juga berat seperti mengurus rumah, keluarga, bahkan harus bekerja ekstra (Setiawati et al., 2020)

4) Ekonomi

Dikatakan bahwa tingkat ekonomi yang rendah dapat memicu tingkat depresi. Depresi meningkat ditemukan pada ibu yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan suami

untuk memenuhi kebutuhan, belum bisa terpenuhi (Setiawati et al., 2020).

5) Dukungan sosial

Faktor psikososial menjadi salah satu faktor yang berkontribusi untuk memperparah depresi postpartum pada ibu. Adanya masalah dalam rumah tangga, seperti keretakan atau masalah, kurangnya dukungan suami dan keluarga, adanya KDRT, adanya gangguan mood yang menimbulkan susah mengontrol emosi dan susah mengendalikan diri (R. Kusuma, 2019). Dukungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap depresi postpartum, semakin tinggi dukungan keluarga maka dapat menurunkan resiko terjadinya depresi postpartum yang lebih parah lagi. Ketika melahirkan ibu sering kali mengalami perubahan suasana hati sehingga dengan adanya dukungan sosial keluarga akan berpengaruh terhadap psikologis ibu setelah melahirkan (Munisah et al., 2021).

Dukungan suami menjadi salah satu faktor pencegah terjadinya depresi pada tingkat yang lebih parah. Hal tersebut karena dukungan suami merupakan salah satu strategi koping yang sangat penting bagi ibu. Dukungan yang dapat diberikan oleh suami seperti dukungan emosional, akan tetapi apabila ibu tidak mendapat dukungan yang baik dapat menjadi faktor resiko terjadinya depresi (Haerunnisa et al., 2021). Takdir et al (2022) menyebutkan bahwa dukungan suami akan menciptakan hubungan baik yang memiliki kesan khusus bagi ibu sebagai hubungan yang positif.

Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa dukungan suami berpengaruh secara signifikan terhadap depresi postpartum.

2. Gejala depresi postpartum

Gejala depresi postpartum bisa bervariasi, namun beberapa tanda umum meliputi:

- a. Merasa sedih atau menangis tanpa alasan
- b. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai
- c. Munculnya rasa tidak berharga atau bersalah yang berlebihan
- d. Kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak
- e. Kelelahan yang berkepanjangan dan kehilangan energi
- f. Kesulitan dalam merawat bayi atau menjalin ikatan emosional dengan bayi
- g. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi (dalam kasus yang parah)

Jika seorang ibu mengalami gejala-gejala ini selama lebih dari dua minggu, penting untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan mental.

3. Dampak Depresi Postpartum

Depresi postpartum tidak hanya memengaruhi ibu namun juga berdampak pada anaknya dan keluarga. Ibu yang mengalami depresi postpartum mungkin mengalami kesulitan untuk menjalin ikatan emosional dengan bayinya. Kondisi ini bisa memengaruhi perkembangan emosional dan kognitif bayi, serta meningkatkan risiko masalah perilaku di kemudian hari.

Selain itu, depresi postpartum juga dapat memengaruhi hubungan dengan pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial ibu. Keluarga yang tidak

memahami kondisi ini mungkin merasa kebingungan atau kecewa, yang bisa memperburuk keadaan emosional ibu.

4. Cara Mengatasi Depresi Postpartum

Mengatasi depresi postpartum memerlukan kombinasi dukungan emosional, terapi, dan terkadang obat-obatan. Berikut beberapa cara yang dapat membantu ibu mengatasi kondisi ini (Maliszewska et al., 2016; Mohebi et al., 2018; Negron et al., 2013; Olii et al., 2023; Pawluski, 2024):

- a. Terapi Bicara: Terapi psikologis yaitu terapi perilaku kognitif (CBT) atau terapi interpersonal (IPT), dapat memudahkan ibu untuk mengidentifikasi dan mengatasi pola pikir negatif serta belajar menghadapi stres.
- b. Dukungan Sosial: adanya dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman sangat penting dalam menurunkan kejadian DPP. Memiliki seseorang yang mau mendengarkan dan membantu dalam merawat bayi bisa meringankan beban ibu.
- c. Obat-obatan Antidepresan: Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan obat antidepresan. Ibu yang sedang menyusui perlu berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan obat yang diberikan aman untuk bayi.
- d. Istirahat yang Cukup dan Merawat Diri: Walaupun sulit, mendapatkan waktu untuk beristirahat atau melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu ibu merasa lebih baik. Ini bisa termasuk tidur cukup, makan makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.

- e. Bergabung dalam Kelompok Dukungan: Kelompok dukungan ibu baru atau komunitas yang memahami kondisi ini bisa membantu ibu merasa didengar dan dipahami.
- f. Dukungan dari Tenaga Kesehatan: Bidan, perawat, atau konselor kesehatan mental dapat menjadi sumber dukungan yang penting. Mereka dapat memberikan informasi dan saran yang berguna untuk mengatasi depresi postpartum.

C. Psikosis

Depresi postpartum yang tidak teratasi dapat menjadi gangguan jiwa serius yaitu postpartum psikosis. Postpartum psikosis merupakan keadaan seorang ibu mengalami tekanan jiwa yang bisa berlangsung hingga setahun dan bisa kambuh sewaktu-waktu. Gejala psikosis postpartum memiliki kesamaan seperti depresi postpartum. Namun, beberapa situasi bisa muncul dalam periode ini seperti ibu bisa berhalusinasi dan timbul perasaan melukai diri sendiri dan bayinya bahkan bisa bunuh diri atau bahkan membunuh bayinya (Lail, 2019)(Luh et al., 2023).

Psikosis postpartum adalah gangguan mental yang sangat serius dan biasanya muncul dalam beberapa minggu pertama setelah melahirkan, terutama dalam tiga hari hingga satu bulan pascapersalinan. Kondisi ini ditandai oleh gejala seperti delusi, halusinasi, gangguan dalam pola pikir, perubahan suasana hati yang ekstrem, hingga perilaku yang tidak terduga. Psikosis postpartum dianggap sebagai keadaan darurat medis yang membutuhkan perhatian segera, karena dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayinya (Sit et al., 2006).

1. Prevalensi dan Faktor Risiko

Meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan depresi postpartum atau postpartum blues, psikosis postpartum diperkirakan terjadi pada sekitar 1-2 kasus dari setiap 1.000 kelahiran. Wanita dengan riwayat gangguan bipolar atau psikosis sebelumnya memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami kondisi ini. Faktor lain yang berperan meliputi perubahan hormon yang drastis, kurang tidur, serta tekanan emosional atau sosial selama masa postpartum (Kendell et al., 1987; VanderKruik et al., 2017).

2. Penyebab dan Mekanisme Terjadinya

Psikosis postpartum disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Salah satu teori menyebutkan bahwa perubahan hormon yang cepat setelah persalinan, seperti penurunan kadar estrogen dan progesteron, memengaruhi neurotransmitter otak, terutama dopamin dan serotonin. Selain itu, riwayat keluarga dengan gangguan mental juga meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami psikosis postpartum (Bergink et al., 2015).

3. Diagnosis dan Penanganan

Diagnosis psikosis postpartum dilakukan berdasarkan gejala klinis, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam DSM-5 untuk gangguan psikotik. Terapi biasanya melibatkan pemberian obat-obatan seperti antipsikotik dan stabilisator mood, yang kadang dikombinasikan dengan terapi psikologis. Dalam kasus yang berat, rawat inap mungkin diperlukan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Pada beberapa kasus, terapi kejut listrik (ECT) juga dilaporkan efektif dalam menangani kondisi ini (Spinelli, 2009).

4. Prognosis dan Upaya Pencegahan

Dengan intervensi yang tepat, banyak pasien dapat kembali pulih sepenuhnya. Namun, terdapat kemungkinan kekambuhan pada kehamilan berikutnya atau selama episode manik di masa mendatang. Upaya pencegahan meliputi pemantauan ketat pada wanita dengan risiko tinggi, terutama pada trimester akhir kehamilan dan awal periode postpartum (Jones et al., 2014).

D. Perbedaan Postpartum Blues, Depresi Postpartum dan Psikosis

Ketiga kondisi ini adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah melahirkan. Meski memiliki beberapa kesamaan, ketiganya berbeda dalam hal gejala, tingkat keparahan, dan durasi. Berikut penjelasan masing-masing:

Tabel 2.1 Perbandingan Jenis Gangguan Psikologis: Postpartum Blues, Depresi Postpartum dan Psikosis Postpartum

kategori	Postpartum blues	Depresi postpartum	Psikosis postpartum
Insiden Gejala	60-80% Mood yang labil, rasa sentitif, mudah menangis, penurunan nafsu makan, adanya masalah tidur, umumnya terjadi dalam 2 minggu atau kurang dari 7 hari.	10-20% Kecemasan yang berlebih, muncul rasa kehilangan, kesedihan, hilang harapan, menyalahkan diri sendiri, gangguan percaya diri, kehilangan tenaga, lemah,	3-5% Semua gejala yang ada di depresi post partum ditambah gejala halusinasi, delusi dan agitasi

		penurunan nafsu makan, penurunan BB, sulit tidur, rasa khawatir yang berlebihan, ada rasa bersalah dan ada ide bunuh diri	
Kejadian	1-10 hari setelah kelahiran bayinya	1-2 bulan setelah kelahiran bayinya	Pada umumnya terjadi akhir masa nifas
Penyebab	Adanya perubahan hormonal dan muncul stresor dalam hidup	memiliki riwayat depresi, respon hormonal, kurang dukungan sosial	Memiliki riwayat penyakit mental, perubahan hormon, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit bipolar
Penanganan	Support dan empati	Konseling	Psycho therapy dan terapi obat

E. Skrining gangguan psikologis masa nifas

Pengukuran postpartum blues dilakukan dengan menggunakan prosedur standar yang sesuai, seperti melalui wawancara atau laporan diri (self-report) (Robertson et al., 2008). Alat ukur standar yang cocok untuk mengukur postpartum blues harus mencakup pernyataan yang mengevaluasi perubahan emosional dan mood ibu. Salah satu instrumen yang telah digunakan sejak tahun 1973 adalah instrumen Pitt, Stein, dan Kenerley (Faisal-Cury et al., 2008), yang mengandung pernyataan terkait perubahan emosional dan mood yang digunakan untuk mengidentifikasi kejadian postpartum blues.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) merupakan suatu alat ukur yang telah diuji dan dikembangkan untuk mendeteksi tingkat perubahan perasaan dan emosi selama tujuh hari pasca melahirkan. Ismail menggunakan EPDS dalam penelitiannya untuk mengidentifikasi faktor risiko yang memengaruhi kejadian maternity blues di RSUP Persahabatan Jakarta. Sementara itu, Nurbaeiti menggunakan EPDS untuk menganalisis hubungan antara karakteristik ibu, kondisi bayi baru lahir, dukungan sosial, dan kepuasan pernikahan dengan depresi postpartum pada ibu primipara di RSAB Harapan Kita Jakarta (Mulyati & Khoerunisa, 2018).

EPDS adalah kuisisioner yang terdiri atas 10 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dari masing-masing item pertanyaan. Setiap jawaban yang dipilih ibu memiliki skor dengan rentang 0-3 yang mencerminkan kesesuaian dengan suasana hati yang dirasakan saat pemeriksaan (Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, 2018). Saat ini EPDS merupakan metode skrining yang paling umum digunakan dalam mendeteksi gangguan psikologis pada ibu nifas. Skrining

EPDS terdiri dari berbagai bentuk metode yaitu mulai dari lembar kuisioner, layar telepon dan berbasis komputer.

1. Keuntungan EPDS

- a. Sederhana dan Mudah digunakan oleh perawat, bidan, petugas kesehatan lain
- b. Praktis dan perlu waktu singkat untuk menjawab kuesioner sesuai perasaan ibu 7 hari terakhir. (
- c. Mampu menskrining secara dini gangguan psikologis pada masa nifas
- d. Mudah diterima oleh pasien
- e. Skrinning ini gratis

2. Kekurangan EPDS:

- a. Hanya bisa mendeteksi gejala, bukan mendiagnosis depresi pasca persalinan
- b. Penyebab dari depresi pasca persalinan tidak bisa ditentukan dari skrinning ini.

3. Cara penilaian EPDS

- a. Pertanyaan 1, 2, dan 4 mendapatkan nilai 0-3 dengan opsi paling atas mendapatkan nilai 0 dan opsi paling bawah mendapatkan nilai 3
- b. Pertanyaan 3,5 sampai dengan 10 merupakan penilaian terbalik, dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 3 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 0
- c. Pertanyaan 10 merupakan pertanyaan sensitif yang menunjukkan keinginan bunuh diri.
- d. Nilai maksimal dari 10 pertanyaan adalah 30
- e. Batas nilai yang menunjukkan gejala depresi dengan cut point 10
- f. Skor yang tinggi menyatakan semakin berat gangguan depresi yang dialami
(Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, 2018; Gondo HK, 2017).

4. Cara Mengisi EPDS

- a. Ibu diharapkan dapat memberikan jawaban yang paling sesuai dengan perasaan ibu dalam 7 hari terakhir.
 - b. 10 pertanyaan EPDS harus dijawab.
 - c. Ibu dilarang untuk mendiskusikan pertanyaan EPDS dengan orang lain. Ibu harus menjawab EPDS sesuai suasana hati ibu
 - d. Ibu diwajibkan menyelesaikan kuisisioner ini sendiri, kecuali ibu mengalami kesulitan dalam memahami bahasa atau tidak bisa membaca.
5. Adapun interpretasi dari hasil penilaian EPDS, antara lain:
- a. Total nilai EPDS 9-10 maka dianjurkan untuk mendapatkan skrining selanjutnya.
 - b. Pada ibu nifas yang memiliki total skor lebih dari 10, memiliki risiko tinggi terjadi depresi postpartum.
 - c. Khusus pertanyaan nomor 10, jika jawaban "ya" cukup sering, menjadi tanda bahwa ibu membutuhkan perawatan psikiatri dengan segera. Wanita yang mengalami gangguan fungsi seperti adanya penghindaran dari keluarga dan teman, tidak mampu menjaga personal hygiene, serta tidak mampu merawat bayinya. Hal tersebut juga merupakan suatu keadaan yang memerlukan pertolongan dari psikiatri.
 - d. Ibu dengan skor 5 dan 9 tanpa adanya pikiran bunuh diri sebaiknya dilakukan evaluasi ulang setelah 2 minggu untuk menentukan apakah depresi tersebut membaik atau memburuk.

Gejala psikologis dan fisik yang khas dalam depresi tercermin dalam pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner EPDS. Misalnya, perasaan tertekan diungkapkan dalam pertanyaan pertama, di

mana pasien diminta menilai kemampuannya untuk tertawa dan merasakan hal-hal yang menyenangkan dalam 7 hari terakhir. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang menyenangkan dijelaskan dalam pertanyaan kedua, yang mengukur kemampuan pasien untuk menikmati kegiatan yang biasanya mereka sukai dalam periode yang sama. Perasaan bersalah dieksplorasi melalui pertanyaan ketiga, yang meminta pasien untuk mengevaluasi sejauh mana mereka menyalahkan diri sendiri dalam situasi tertentu selama 7 hari terakhir.

Salah satu faktor risiko depresi, seperti perasaan cemas, khawatir, atau takut tanpa alasan yang jelas, tercermin dalam pertanyaan keempat dan kelima dari kuesioner EPDS. Energi yang rendah atau perasaan kelelahan yang tak dapat dijelaskan dicerminkan dalam pertanyaan keenam, mengevaluasi sejauh mana pasien merasa kewalahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dalam seminggu terakhir. Gangguan tidur, sebagai salah satu gejala fisik depresi, dijelaskan dalam pertanyaan ketujuh yang mengukur kesulitan tidur yang disebabkan oleh perasaan yang tidak bahagia selama seminggu terakhir.

Gejala psikologis depresi, seperti rasa sedih, malaise, dan kecenderungan menangis, tercermin dalam pertanyaan kedelapan dan kesembilan. Pertanyaan kesepuluh, yang menggali kemungkinan munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri, menyoroti pentingnya intervensi psikiatri segera jika jawaban pasien menunjukkan kecenderungan ini. Skor EPDS yang tinggi, di atas 10, mencerminkan tingkat keparahan depresi yang bervariasi, dan nilai skala ini mencerminkan perasaan pasien dalam satu minggu terakhir. Evaluasi ulang

disarankan untuk pasien dengan skor antara 5 hingga 9 setelah dua minggu, terutama jika tidak ada pikiran untuk bunuh diri, untuk menilai perubahan dalam episode depresi. Skrining dengan EPDS pada minggu pertama bisa menjadi prediktor potensial untuk depresi postpartum pada minggu keempat dan kedelapan, terutama pada wanita yang awalnya tidak menunjukkan gejala depresi. Meskipun EPDS tidak dapat mendeteksi gangguan neurosis, phobia, kecemasan, atau kepribadian, namun dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi potensi depresi antepartum. (Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, 2018).

Studi yang dilakukan oleh Latifah dan Hartati (2006) telah menginvestigasi efektivitas instrumen EPDS dengan membandingkannya dengan skala BDI (Beck Depression Inventory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa EPDS cukup efektif dalam mengevaluasi kejadian depresi postpartum, sementara BDI lebih sesuai untuk menilai kasus depresi secara umum.

Edinburgh Postnatal Depression Scale¹ (EPDS)

Name: _____ Address: _____

Your Date of Birth: _____

Baby's Date of Birth: _____ Phone: _____

As you are pregnant or have recently had a baby, we would like to know how you are feeling. Please check the answer that comes closest to how you have felt **IN THE PAST 7 DAYS**, not just how you feel today.

Here is an example, already completed.

I have felt happy:

- ☐ Yes, all the time
☒ Yes, most of the time This would mean: "I have felt happy most of the time" during the past week.
☐ No, not very often Please complete the other questions in the same way.
☐ No, not at all

In the past 7 days:

- | | |
|---|--|
| 1. I have been able to laugh and see the funny side of things
☐ As much as I always could
☐ Not quite so much now
☐ Definitely not so much now
☐ Not at all | *6. Things have been getting on top of me
☐ Yes, most of the time I haven't been able to cope at all
☐ Yes, sometimes I haven't been coping as well as usual
☐ No, most of the time I have coped quite well
☐ No, I have been coping as well as ever |
| 2. I have looked forward with enjoyment to things
☐ As much as I ever did
☐ Rather less than I used to
☐ Definitely less than I used to
☐ Hardly at all | *7. I have been so unhappy that I have had difficulty sleeping
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, sometimes
☐ Not very often
☐ No, not at all |
| *3. I have blamed myself unnecessarily when things went wrong
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, some of the time
☐ Not very often
☐ No, never | *8. I have felt sad or miserable
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, quite often
☐ Not very often
☐ No, not at all |
| 4. I have been anxious or worried for no good reason
☐ No, not at all
☐ Hardly ever
☐ Yes, sometimes
☐ Yes, very often | *9. I have been so unhappy that I have been crying
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, quite often
☐ Only occasionally
☐ No, never |
| *5. I have felt scared or panicky for no very good reason
☐ Yes, quite a lot
☐ Yes, sometimes
☐ No, not much
☐ No, not at all | *10. The thought of harming myself has occurred to me
☐ Yes, quite often
☐ Sometimes
☐ Hardly ever
☐ Never |

Administered/Reviewed by _____ Date _____

¹Source: Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *British Journal of Psychiatry* 150:782-786.

²Source: K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199

Users may reproduce the scale without further permission providing they respect copyright by quoting the names of the authors, the title and the source of the paper in all reproduced copies.

Gambar 3.2: form EPDS

BAB 4

DUKUNGAN KELUARGA PADA IBU NIFAS

Dukungan suami adalah suatu bentuk perlakuan yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa perhatian, kasih sayang, dan penghargaan agar tercapainya kesejahteraan. Dukungan suami dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaannya dalam menjalankan peran barunya (Winarni et al., 2018) Dukungan suami berdampak positif bagi istri dalam mengatasi kecemasan yang dirasakan dan membantu dalam menyelesaikan masalah selama melakukan adaptasi pada masa nifas. Dengan adanya dukungan suami maka dapat meningkatkan hubungan kasih sayang kepada istri dan memberikan dukungan psikologis yang membuatnya menjadi lebih percaya diri dan menstabilkan stress yang terjadi pada ibu, hubungan yang positif yang diberikan oleh suami dapat membantu ibu selama masa postpartum (Mage et al., 2020)(Luh et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitrah, Helina, dan Hamidah (2019), Postpartum Blues disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan selama kehamilan dan persalinan (38,71%), aspek psikososial (19,35%), kondisi dan kualitas bayi yang baru lahir (16,13%), serta elemen spiritual (9,78%). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 43,2% dari ibu yang tidak mendapat dukungan dari suami mereka mengalami postpartum blues. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Mariangela dkk. (2019) menemukan bahwa pelecehan secara verbal dapat

meningkatkan risiko depresi postpartum blues sedang (OR = 1,58) dan depresi postpartum blues berat (OR = 1,69). Selain itu, pelecehan fisik juga dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi postpartum blues berat (OR = 2,28), dan wanita yang mengalami lebih dari tiga bentuk perlakuan buruk memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi postpartum blues sedang (OR = 2,90) dan depresi postpartum blues berat (OR = 3,86).

Dukungan sosial diartikan sebagai bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama dari orang yang dicintai dalam bentuk informasi perhatian, dan rasa dihargai (Cobb, 1976; Cohen & Wills, 1985; Seeman, 1996). Perasaan itu mungkin datang dari suami atau pasangan, kerabat, teman/sahabat, rekan kerja, dan ikatan komunitas. Dukungan sosial secara efektif mampu mengurangi tekanan psikologis, seperti depresi atau kecemasan, stres dan dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan fisik, termasuk penyesuaian positif terhadap penyakit jantung koroner, diabetes, penyakit paru-paru, penyakit jantung, arthritis, dan kanker. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan penyakit, mempercepat pemulihan dari penyakit ketika penyakit itu terjadi, dan menguranginya risiko kematian akibat penyakit serius. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial selama masa-masa stres bisa sangat menyusahkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan dukungan sosial yang tinggi yang tidak dapat memperolehnya, termasuk orang lanjut usia dan korban peristiwa kehidupan yang tiba-tiba tidak terkendali. Dukungan sosial telah dipelajari dengan berbagai cara. Penelitian telah meneliti keyakinan atau persepsi individu tentang ketersediaan dukungan serta dukungan sosial (Kim et al., 2008).

Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh suami kepada ibu nifas, yaitu memberikan motivasi kepada ibu agar

ibu menjadi lebih percaya diri, memberikan kepercayaan kepada ibu dalam menjaga dan merawat bayinya, pemenuhan kebutuhan untuk ibu dan bayi, memberikan dukungan berupa informasi yang dibutuhkan oleh ibu (Nadhiroh et al., 2022)

A. Faktor-faktor yang Memengaruhi Dukungan Suami/Keluarga

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi dukungan suami (Safaat, 2021) yaitu :

1. Tingkat pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang dapat memengaruhi dukungan, semakin rendah pengetahuan yang dimiliki suami maka akses untuk mendapatkan informasi untuk istrinya juga akan berkurang. Secara tidak langsung pengetahuan dapat mempengaruhi peristiwa depresi postpartum, karena pengetahuan mempengaruhi pola pikir seseorang.
2. Budaya
Dibeberapa wilayah masih banyak masyarakat yang masih menggunakan budaya tradisional yaitu tugas istri adalah melayani semua kebutuhan dan keinginan suami. Kebiasaan tersebut dapat memengaruhi perlakuan suami terhadap kesehatan reproduksi sehingga tidak ada dukungan yang diberikan oleh suami kepada ibu dan dapat mengakibatkan resiko depresi postpartum.
3. Status perkawinan
Pasangan suami istri yang memiliki status perkawinan tidak sah, dukungan suami akan menjadi kurang dibandingkan dengan pasangan dengan status perkawinan yang sah.
4. Status sosial ekonomi

Suami yang memiliki status sosial ekonomi yang baik akan lebih mampu dalam memberikan dukungan kepada istrinya.

(Luh et al., 2023, 2024; Mohebi et al., 2018; Ntaouti et al., 2020; Werner et al., 2024)

B. Peran Suami dalam Mencegah Postpartum Blues Pada Ibu Nifas

Sebanyak 80% dari kelompok responden yang memiliki tingkat dukungan keluarga rendah menunjukkan gejala depresi post partum, sementara hanya 7,9% dari kelompok yang mendapat dukungan keluarga tinggi yang mengalami gejala tersebut. Hasil penelitian ini menegaskan adanya hubungan signifikan ($p\text{-value} < 0,001$) antara tingkat dukungan keluarga dan kejadian gejala depresi postpartum (Parwati et al., 2022). Responden yang menerima dukungan yang baik dari keluarga cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami depresi postpartum dibandingkan dengan mereka yang menerima dukungan yang minim. Dalam konteks ini, semua responden yang tidak mendapat dukungan yang memadai mengalami gejala depresi postpartum. Wanita yang merasakan dukungan yang memadai dari keluarga akan merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai, sementara kurangnya dukungan dapat membuat wanita lebih sensitif dan rentan terhadap depresi.

Secara psikologis, tekanan psikologis sering dialami oleh wanita setelah melahirkan. Meskipun awalnya merasa bahagia dengan kelahiran bayi, pada minggu pertama dan kedua setelah melahirkan, banyak wanita mulai merasakan gangguan suasana hati, perasaan sedih, dan tekanan. Dukungan keluarga merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga sehingga individu yang

menerimanya merasa dihargai dan diperhatikan, yang pada gilirannya membantu dalam penyesuaian individu (Alifariki, L.O, Kusnan et al., 2020).

Dukungan keluarga yang kurang cenderung meningkatkan risiko perubahan emosi pasca melahirkan lebih daripada dukungan yang memadai. Dukungan keluarga juga memengaruhi tanggung jawab seorang ibu dalam merawat bayi dan rumah tangga. Dengan dukungan keluarga yang memadai, tanggung jawab ibu dapat terasa lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang mendapat dukungan yang minim. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penilaian, yang semuanya berperan dalam membantu ibu beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu.

Studi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan keluarga dapat mengurangi sindrom baby blues, mengurangi risiko gangguan psikologis, serta mempercepat proses kesembuhan. Dukungan keluarga, sebagai bagian dari dukungan sosial, memiliki peran penting dalam kesejahteraan ibu pasca melahirkan. Faktor psikologis, termasuk dukungan keluarga terutama dari suami, secara signifikan memengaruhi kejadian post-partum blues. Oleh karena itu, dalam asuhan pasca persalinan, dukungan keluarga sangat diperlukan untuk membantu ibu dalam mengatasi tantangan menjadi seorang ibu yang baru.

Menurut Rahayuningsih (2020), ibu yang baru saja melahirkan membutuhkan dukungan untuk membantu mereka menghadapi tantangan sehari-hari. Dukungan ini melibatkan interaksi antara individu dan orang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar individu, seperti kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dan merasa aman agar

dapat meraih kebahagiaan. Dukungan dapat berupa informasi atau nasehat verbal maupun non-verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang dilakukan karena adanya kedekatan. Pasangan dan orang tua dari ibu pasca melahirkan adalah sumber dukungan yang sangat penting dan harus tersedia setelah kelahiran bayi karena memiliki hubungan dekat dengan ibu. Oleh karena itu, peran suami dalam memberikan dukungan kepada ibu pasca melahirkan dianggap sangat penting dan signifikan dalam membantu ibu melewati masa transisi dari kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarni, Winarni, dan Ikhlasiah (2018) mengenai pengaruh dukungan suami terhadap kondisi psikologis ibu nifas menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan kondisi psikologis ibu pasca melahirkan ($p = 0,021$). Dukungan yang diberikan oleh suami memiliki dampak besar dalam mengurangi stres atau gangguan psikologis pada ibu pasca melahirkan, di mana hubungan pernikahan yang kurang harmonis dapat menjadi faktor prediktor terjadinya depresi postpartum. Ibu yang mengalami gangguan psikologis biasanya mengeluhkan kurangnya komunikasi antara pasangan. Suami yang mendukung dan menjalankan peran dengan baik dapat mengurangi tingkat stres ibu dan meningkatkan suasana hati ibu pasca melahirkan.

Studi lain yang dilakukan oleh Dinarum dan Rosyidah (2020) mengenai pengaruh dukungan suami terhadap kejadian postpartum blues menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dukungan suami dengan kejadian postpartum blues. Peran suami selama masa nifas sangat penting dan dibutuhkan oleh ibu, di mana dukungan fisik dan emosional yang diberikan oleh suami dapat menjaga

stabilitas kondisi psikologis ibu. Dalam memberikan dukungan, suami perlu memiliki pengetahuan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh ibu pasca melahirkan untuk membantu melewati masa nifas dengan baik.

Dukungan sosial dari keluarga dan suami sangat penting, tetapi ibu ekspatriat seringkali mengalami kesulitan mendapatkan dukungan yang cukup. Temuan menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan sosial yang unik di UEA, mengingat populasi yang beragam (Hanach et al., 2024)

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal dengan anggota keluarga memainkan peran penting dalam depresi pascapersalinan dan kualitas tidur pada wanita Tiongkok melalui dukungan sosial. Meningkatkan hubungan antara ibu baru dengan suami atau ibu mertua, dan kemudian meningkatkan dukungan sosial, dapat mengurangi depresi pascapersalinan dan gangguan tidur (Qi et al., 2022)

C. Dukungan Intrumental

Dukungan instrumental mengacu pada bantuan praktis yang diberikan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu. Bantuan ini penting karena ibu nifas sering kali menghadapi keterbatasan energi dan waktu. Jenis dukungan ini melibatkan bantuan fisik atau praktis untuk meringankan beban ibu. Pada masa nifas, ibu sering membutuhkan waktu untuk pulih secara fisik setelah melahirkan

Contoh dukungan instrumental yang bisa diberikan oleh suami/pasangan maupun anggota keluarga lainnya :

1. Membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, atau membersihkan rumah.
2. Merawat bayi, seperti mengganti popok atau menenangkan bayi saat menangis.
3. Mengatur waktu kunjungan keluarga atau tamu agar ibu dapat beristirahat.
4. Menyediakan kebutuhan logistic ibu, seperti makanan bergizi, perlengkapan bayi, atau obat-obatan.

Hasil penelitian:

Penelitian oleh Leahy-Warren et al. (2012) menunjukkan bahwa dukungan instrumental dari pasangan dan keluarga dekat berkontribusi pada pemulihan fisik ibu dan mengurangi tingkat stres. Affonso et al. (2000): Bantuan praktis dari pasangan dan keluarga memungkinkan ibu untuk fokus pada pemulihan diri dan perawatan bayi, yang secara signifikan mengurangi stres.

Leahy-Warren et al. (2012): Dukungan instrumental secara langsung berkorelasi dengan kepuasan ibu terhadap peran keluarganya dalam masa nifas.

D. Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah bentuk perhatian, pengertian, dan kasih sayang yang diberikan oleh anggota keluarga, terutama pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional membantu ibu merasa didengar, dipahami, dan dihargai dalam peran barunya.

Adapun bentuk dukungan emosional yang diberikan oleh suami/ pasangan kepada ibu nifas:

1. Pendampingan aktif: menemani ibu saat ia merawat bayinya, berbicara dengannya atau mendengar keluhan ibu

2. Validasi emosi: memberikan pengakuan bahwa perasaan ibu adalah wajar, seperti merasa cemas, atau khawatir maupun bingung
3. Pemberian kasih sayang : melalui sentuhan fisik seperti pelukan atau tindakan seperti memberikan ucapan dukungan.

Contoh dukungan emosional yang bisa dilakukan oleh suami ataupun anggota keluarga lainnya kepada ibu nifas dan menyusui, yaitu:

1. Memberikan semangat dan dorongan positif.
2. Mendengarkan keluh kesah ibu tanpa menghakimi.
3. Memberikan pelukan atau menunjukkan rasa kasih sayang secara fisik.
4. Menunjukkan perhatian dan empati pada ibu nifas
5. Suami yang secara aktif menunjukkan apresiasi, baik melalui kata-kata maupun tindakan, dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu. Pujian sederhana atas usaha ibu dalam merawat bayi bisa sangat berarti.

Penelitian oleh Dennis dan Ross (2006) menemukan bahwa ibu yang merasa didukung secara emosional oleh pasangan maupun anggota keluarga lainnya cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan risiko postpartum depression yang lebih kecil. Demikian juga dengan penelitian Heringhausen et al. (2019) bahwa Ibu yang mendapatkan dukungan emosional lebih mampu mengatasi tantangan masa nifas dan memiliki risiko lebih rendah terhadap postpartum blues. Menurut Beck (2001): dukungan emosional dari pasangan dianggap sebagai prediktor utama keberhasilan ibu dalam menjalani masa nifas.

E. Dukungan Informasi

Dukungan informasional melibatkan pemberian saran, informasi, atau edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi dan kesehatan diri. Informasi ini dapat berasal dari anggota keluarga yang berpengalaman, seperti orang tua atau saudara, maupun akses terhadap sumber terpercaya.

Contoh dari dukungan informasional yang dilakukan suami dan keluarga kepada ibu nifas:

1. Memberikan tips praktis tentang menyusui atau mengatur pola tidur bayi.
2. Membantu ibu memahami tanda-tanda yang memerlukan perhatian medis.
3. Mengarahkan ibu ke sumber informasi terpercaya, seperti bidan atau dokter.

Menurut sebuah studi oleh Shorey et al. (2015), ibu yang mendapatkan dukungan informasional merasa lebih percaya diri dalam merawat bayi dan mengatasi tantangan postpartum.

F. Dukungan penilaian atau penghargaan

Dukungan penilaian atau penghargaan yaitu dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat untuk orang lain. Suami dapat memberikan dukungan penilaian dengan memberikan umpan balik, membimbing, dan bisa menjadi sumber pemberian support, penghargaan, dan perhatian.

G. Dukungan Suami saat Persalinan

Dukungan suami menjadi salah satu strategi koping yang sangat bermanfaat bagi ibu nifas dan mampu mencegah terjadinya depresi yang berat pada ibu nifas. Dalam penelitian ini dukungan suami dibagi menjadi empat

yaitu dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Nilai rata-rata (mean) terendah adalah pada dukungan informasional yaitu sebesar 11.22 dan nilai Mean tertinggi ada pada dukungan penghargaan sebesar 15.17. Friedman (2021) mengatakan bahwa dukungan informasional adalah dukungan informatif yang diberikan melalui pemberian informasi pada situasi atau kondisi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan dukungan penghargaan adalah pemberian dukungan dengan cara memberikan umpan balik, membimbing, dan bisa menjadi sumber pemberian support, penghargaan, dan perhatian. Sebagian besar responden mendapatkan dukungan penghargaan yang baik dari suaminya yaitu suami menyemangati ibu ketika proses persalinan, suami menghargai keinginan atau keputusan ibu, memuji kemampuan istrinya saat proses persalinan, memberikan komentar positif, serta menerima menerima perubahan fisik dan psikologis ibu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 33 sebagian besar dijawab sering dilakukan oleh suami kepada ibu. Pada dukungan informasional sebagian besar suami ibu hanya mendengarkan informasi dari bidan atau petugas kesehatan lainnya dan jarang mencari informasi dari media yang lain. Rahmayuly (2022) menyebutkan bahwa kurangnya dukungan suami berupa tindakan yang nyata seperti perhatian, membangun komunikasi yang baik, menciptakan hubungan emosional yang mendalam merupakan faktor penyebab timbulnya depresi postpartum. Seorang ibu yang mengalami depresi akan mengurangi semangatnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan adanya dukungan dari suami berupa perhatian baik secara emosional maupun fisiologisnya. Dukungan tersebut akan

membuat ibu merasa bahwa ada yang peduli pada situasi dan keadaannya saat ini (Takdir et al., 2022). Dukungan suami memberi pengaruh untuk mengurangi depresi yang dialami ibu postpartum. Ibu yang tidak mendapat dukungan dari suami beresiko lima kali lipat mengalami depresi (Setiawati et al., 2020).

BAB 5

PENUTUP

Buku ini telah menguraikan dengan komprehensif tentang betapa pentingnya dukungan keluarga dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan psikologis ibu pasca melahirkan. Masa pasca salin adalah salah satu periode paling kritis dalam kehidupan seorang perempuan. Di satu sisi, ibu mengalami kebahagiaan atas kelahiran bayinya, namun di sisi lain ia juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan fisik, lonjakan hormon, kelelahan, kurangnya istirahat, serta tekanan sosial dan emosional dari lingkungan sekitarnya.

Dalam kondisi tersebut, peran keluarga menjadi tidak tergantikan. Dukungan keluarga, baik berupa perhatian emosional, bantuan praktis, maupun penguatan sosial, terbukti mampu mengurangi risiko gangguan psikologis yang sering terjadi pada ibu, seperti postpartum blues, depresi postpartum, bahkan postpartum psychosis. Kehadiran pasangan, orang tua, atau anggota keluarga lainnya dapat menjadi penguat mental yang membantu ibu merasa didukung, dipahami, dan tidak sendirian dalam menghadapi peran barunya. Dukungan tersebut juga menciptakan suasana yang kondusif untuk pemulihan fisik dan psikologis ibu.

Lebih jauh lagi, dukungan keluarga memiliki dampak yang sangat luas. Dukungan yang memadai tidak hanya membantu ibu menghadapi masa-masa sulit setelah melahirkan, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan bayi. Dengan kondisi psikologis yang stabil, ibu dapat membangun ikatan yang kuat dengan bayinya, yang menjadi fondasi penting dalam perkembangan emosional dan sosial

anak. Selain itu, keluarga yang mendukung menciptakan lingkungan yang harmonis, sehingga semua anggota keluarga dapat merasakan kesejahteraan.

Dukungan keluarga juga merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketika ibu mendapatkan dukungan yang optimal, ia dapat menjalani perannya dengan lebih percaya diri dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga, terutama pasangan, untuk memahami dan mengambil peran aktif dalam memberikan dukungan kepada ibu pasca melahirkan. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perhatian emosional yang mendalam dan komunikasi yang terbuka.

Penulis juga ingin menekankan bahwa mendukung ibu pasca salin bukan hanya tanggung jawab individu keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan dari komunitas dan tenaga kesehatan. Dengan sinergi yang baik antara keluarga, masyarakat, dan layanan kesehatan, ibu akan mendapatkan dukungan holistik yang dapat membantu mereka melewati fase ini dengan baik.

Penulis berharap, buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang pentingnya dukungan keluarga dalam konteks psikologis ibu pasca melahirkan. Pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wawasan teoretis, tetapi juga mendorong tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi ibu. Selain memberikan dukungan dalam bentuk dukungan emosional, instrumental, informasi dan spriritual, penulis sangat berharap suami maupun keluarga bisa menjadi model dalam pencegahan terjadinya postpartum. Dukungan

suami dan keluarga sangat membantu ibu dalam melewati setiap perubahan fisik maupun psikologis yang membuat ibu dengan mudah beradaptasi. Suami dan keluarga bisa juga melakukan deteksi dini dengan formular EPDS agar segala penyimpangan bisa segera diatasi dengan cepat dan tepat.

Akhir kata, meskipun penulis telah berusaha menyampaikan isi buku ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa masih banyak aspek yang mungkin belum dibahas secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima masukan, kritik, dan saran dari pembaca sebagai upaya untuk menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifariki, L.O, Kusnan, A., Binekada, I. M. C., & Usman, A. N. (2020). The proxy determinant of complementary feeding of the breastfed child delivery in less than 6 months old infant in the fishing community of Buton tribe. *Enfermeria Clinica*, 30, 544–547.
- Ariyanto, I. (2009). *Hubungan Antara Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Dengan Kecemasan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Carlson, K., Mughal, S., Azhar, Y., & Siddiqui, W. (2024). *Postpartum Depression*.
- Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. . (2018). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *Cambridge University Press*.
- Cunningham, F. G., Lenevo, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Rouse, D. J., & Spong, C. Y. (2017). *Obstetri Williams* (23rd, vol 1 ed.). EGC.
- Dinarum, & Rosyidah, H. (2020). Literatur Review : Pengaruh Dukungan Suami Terhadap Kejadian Postpartum Blues. *Call for Paper Seminar Nasional Kebidanan*, 2(2), 90–95.
- Đuričeková, B., Škodová, Z., & Bašková, M. (2024). Risk factors associated with postpartum depression and PTSD after birth in a sample of Slovak women. *Heliyon*, 10(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23560>
- Fatmawati, D. A. (2015). Faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian postpartum blues. *Eduhealth*, 5(2).

- Garapati, J., Jajoo, S., Aradhya, D., Reddy, L. S., Dahiphale, S. M., & Patel, D. J. (2023). Postpartum Mood Disorders: Insights into Diagnosis, Prevention, and Treatment. *Cureus*, 15(7). <https://doi.org/10.7759/cureus.42107>
- Gondo HK. (2017). Skrining Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Pada Postpartum Blues. *Bagian Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*.
- Hanach, N., Radwan, H., Bani Issa, W., Saqan, R., & de Vries, N. (2024). The perceived mental health experiences and needs of postpartum mothers living in the United Arab Emirates: A focus group study. *Midwifery*, 132(March), 103977. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.103977>
- Herliawati, P. A., Iit, K., Nengah, N., Murni, A., Fortunata, G., Elo, B., & Khodijah, U. P. (n.d.). *KESEHATAN MENTAL PADA IBU HAMIL*.
- Juliastuti, Lindayani, I. K., Wulandari, R. F., Ekajayanti, P. P. N., Destrikasari, C., Rahayu, B., Saudia, B. E. P., Veri, N., Fatmawati, & Parwati, N. W. M. (2021). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Media Sains Indonesia.
- Kemendes RI. (2019). Panduan Pelayanan Pasca Persalinan bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir. In *Kementerian Kesehatan RI*.
- Kim, H. S., Sherman, D. K., & Taylor, S. E. (2008). Culture and Social Support. *American Psychologist*, 63(6), 518–526. <https://doi.org/10.1037/0003-066X>
- Lindayani, I. K., & Marhaeni, G. A. (2019). *Prevalensi dan Faktor Risiko Depresi Post Partum di Kota Denpasar Tahun 2019*. 8511, 100–109.
- Luh, N., Ariani, L., Wayan, N., Parwati, M., Kadek, N., & Dwiyantri,

- N. (2024). *Efektivitas Pijat Punggung Oleh Suami terhadap Penurunan Skor EPDS Pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Denpasar Selatan Jurnal ILKES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*. 15(1).
- Luh, N., Gayatri, P., Wayan, N., Parwati, M., Kadek, N., & Dwiyantri, N. (2023). Depresi Postpartum: Studi Retrospektif dengan Menganalisis Dukungan Suami Saat Persalinan *Jurnal ILKES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*. *Jurnal ILKES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 14(2).
- Maliszewska, K., Świątkowska-Freund, M., Bidzan, M., & Preis, K. (2016). Relationship, social support, and personality as psychosocial determinants of the risk for postpartum blues. *Ginekologia Polska*, 87(6), 442–447. <https://doi.org/10.5603/GP.2016.0023>
- Mohebi, S., Parham, M., Sharifirad, G., & Gharlipour, Z. (2018). *Social Support and Self - Care Behavior Study*. January, 1–6. <https://doi.org/10.4103/jehp.jehp>
- Mulyati, I., & Khoerunisa, S. (2018). *Gambaran Kejadian Gejala Baby Blues Pada Ibu Postpartum Berdasarkan Karakteristik Di Rumah Sakit DR.S lamet Garut Tahun 2018*. 7(2), 143–149.
- Negron, R., Martin, A., Almog, M., Balbierz, A., & Howell, E. A. (2013). Social support during the postpartum period: Mothers' views on needs, expectations, and mobilization of support. *Maternal and Child Health Journal*, 17(4), 616–623. <https://doi.org/10.1007/s10995-012-1037-4>
- Nirwana, A. B. (2011). *Psikologi ibu, bayi dan anak*.
- Ntaouti, E., Gonidakis, F., Nikaina, E., Varelas, D., Creatsas, G., Chrousos, G., & Siahianidou, T. (2020). Maternity blues: risk factors in Greek population and validity of the Greek

version of Kennerley and Gath's blues questionnaire. In *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine* (Vol. 33, Issue 13). <https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1548594>

Oktaputring, D., Susandi, C., & Suroso, S. (2017). Post partum blues: Pentingnya dukungan sosial dan kepuasan pernikahan pada ibu primipara. *Psikodimensia*, 16(2), 151–157.

Olii, N., Salman, S., Abdul, N. A., Astuti, S. C. D., Porouw, H. S., Mohamad, S., Claudia, J. G., & Astuti, E. R. (2023). Literature Riview: Determinants of Postpartum Blues. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(S1), 57–62. <https://doi.org/10.30604/jika.v8is1.1688>

Parwati, N. W. M., Wulandari, I. A., & Haryati, N. P. S. (2022). *Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Gangguan Psikologis Ibu Nifas*.

Pawluski, J. L. (2024). The parental brain, perinatal mental illness, and treatment: A review of key structural and functional changes. *Seminars in Perinatology*, 48(6), 151951. <https://doi.org/10.1016/j.semperi.2024.151951>

Pius Kamsu Moyo, G. (2020). Epidemio-clinical Profile of the Baby Blues in Cameroonian Women. *Journal of Family Medicine and Health Care*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.11648/j.jfmhc.20200601.14>

Purwati, Y., & Kustiningsih, K. (2018). Benefit of Childbirth Care Counseling for Mood of Postpartum Period. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(3), 356–365. <https://doi.org/10.15294/kemas.v13i3.11275>

Qi, W., Liu, Y., Lv, H., Ge, J., Meng, Y., Zhao, N., Zhao, F., Guo, Q., & Hu, J. (2022). Effects of family relationship and social

- support on the mental health of Chinese postpartum women. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04392-w>
- Rahayuningsih, F. B. (2020). *Peningkatan Kualitas Hidup Ibu Nifas*. PT. Nas Media Indonesia.
- Rezaie-Keikhaie, K., Arbabshastan, M. E., Rafiemanesh, H., Amirshahi, M., Ostadkelayeh, S. M., & Arbabisarjou, A. (2020). Systematic Review and Meta-Analysis of the Prevalence of the Maternity Blues in the Postpartum Period. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 49(2), 127–136. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2020.01.001>
- Rini, S., & Kumala, D. F. (2016). *Panduan Asuhan Kebidanan dan Evidence Based Practice*. Deepublish.
- Sumiaty. (2018). *Kebidanan Teori dan Asuhan* (Runjati, S. Umar, & M. Ester (eds.); p. 734). EGC.
- Wahyuningsih, H. P. (2018). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Werner, E., Le, H. N., Babineau, V., & Grubb, M. (2024). Preventive interventions for perinatal mood and anxiety disorders: A review of selected programs. *Seminars in Perinatology*, 48(6), 151944. <https://doi.org/10.1016/j.semperi.2024.151944>
- Winarni, L. M., Winarni, E., & Ikhlasiah, M. (2018). Pengaruh Dukungan Suami Dan Bounding Attachment Dengan Kondisi Psikologis Ibu Postpartum Di Rsud Kabupaten Tangerang Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 3(2), 1–11.
- Winingsih, G. A. M., Salmah, U., Masni, Indriasari, R., Amiruddin, R., & Birawida, A. B. (2021). Prevent postpartum blues

with the implementation of breastfeeding father education model to increase the frequency of breastfeeding in mothers: A systematic review. *Gaceta Sanitaria*, 35, S400–S403.
<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.061>

Yulianti. (2013). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Postpartum Blues*. STIKES U'Budiyah Banda Aceh. STIKES U'Budiyah Banda Aceh.

GLOSARIUM

A

Agitasi: adalah perasaan gelisah, jengkel, dan gugup yang umumnya bisa membuat Anda bergerak mondar-mandir atau meremas-remas tangan tanpa henti.

Anhedonia: adalah ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan atau kebahagiaan dari aktivitas yang biasanya menyenangkan, sering menjadi gejala depresi postpartum

Antepartum: adalah masa kehamilan atau masa sebelum persalinan

B

Baby Blues: adalah kondisi emosi labil yang dialami ibu pascapersalinan, biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga dua minggu. Ditandai dengan perasaan sedih, cemas, atau mudah tersinggung akibat perubahan hormonal dan adaptasi menjadi ibu.

Bipolar: adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati

Bounding : adalah Proses terbentuknya *attachment* atau ikatan dari hubungan antara orang tua dan bayi yang saling mencintai.

C

Cemas : adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup

D

Depresi Postpartum: adalah keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan

Dukungan Emosional: adalah bentuk dukungan dari keluarga yang berfokus pada penyediaan kasih sayang, pemahaman, dan rasa aman kepada ibu setelah melahirkan, untuk membantu mengurangi risiko gangguan psikologis

Dukungan Instrumental: adalah bantuan praktis yang diberikan keluarga kepada ibu, seperti membantu mengurus bayi atau pekerjaan rumah tangga, yang dapat meringankan beban ibu pascapersalinan

Dukungan sosial : adalah bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan, maupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial dekat, antara lain orang tua, saudara, anak, sahabat, teman maupun orang lain dengan tujuan membantu seseorang saat mengalami permasalahan

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (American Psychiatric Association) : adalah alat taksonomik dan diagnostik yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA).

Disforia : adalah kondisi ketika seseorang mengalami perasaan tidak nyaman atau ketidakpuasan secara mendalam

E

Endorphin : adalah zat kimia yang dihasilkan secara alami oleh tubuh memiliki peran sebagai penghilang rasa sakit alami dan

bertanggung jawab atas perasaan senang setelah melakukan aktivitas tertentu serta dapat memberikan energi positif dalam diri seseorang.

Emosional : adalah kondisi yang berada di luar kendali

Eksternal : adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan luar tubuh

Estrogen : adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita.

EPDS : *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) adalah sebuah tes berupa 10 pertanyaan skrining yang dianggap efisien untuk dapat mengidentifikasi kondisi seorang pasien yang berisiko mengalami PPD.

F

FSH: *Follicle-Stimulating Hormone* berperan membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium.

Fenomena : fakta, kejadian, atau keadaan di alam yang diamati atau di observasi

Fobia : rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan

G

GH: *Growth Hormone* berperan meningkatkan ukuran dan volume dari otak, rambut, otot dan organ-organ di dalam tubuh.

H

Hormon: adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ.

Halusinasi : adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada

Hopelessness : adalah keputusasaan

I

Intensitas: adalah keadaan tingkatan, kualitas atau kondisi dan ukuran intensnya.

Insiden : adalah kejadian dari sesuatu yang terjadi, kejadian atau kejadian tak terduga yang tidak mengakibatkan cedera atau penyakit serius

Interpesonal : adalah pertukaran informasi, ide, pendapat dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama.

Immediate postpartum : adalah waktu 0-24 jam setelah melahirkan. ibu telah di perbolehkan berdiri atau jalan-jalan

Insomnia : adalah gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk tidur.

K

Kontraksi: adalah proses pengerutan dan penegangan otot rahim terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin yang ditunjukkan dengan tanda perut ibu bersalin dibagian atas rahim mengencang, sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir.

Kuesioner : adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Konseling: adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien

Konselor : adalah pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling

KTD : adalah kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan merupakan kehamilan yang terjadi dimana salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan terjadinya kehamilan.

Komplikasi : adalah penyakit yang muncul karena adanya efek dari penyakit tertentu yang ada pada tubuh

L

Late postpartum : adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi

Letting go : adalah fase di mana seorang ibu nifas sudah menerima tanggung jawab dan peran barunya sebagai seorang ibu

Let down : adalah refleks keluarnya ASI dari payudara. Refleks ini terjadi ketika saraf dalam payudara terstimulasi (baik oleh hisapan bayi maupun pompa ASI) dan memberi sinyal untuk mengeluarkan hormon oksitosin

M

Massage: adalah suatu seni gerak tangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memelihara kesehatan. Gerak

tangan secara mekanis ini akan menimbulkan rasa tenang dan nyaman bagi penerimanya.

Multipara: adalah ibu yang pernah melahirkan dua kali atau lebih.

Melahirkan : adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau bayi dalam kandungan.

Mekanisme coping : adalah sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk menguasai situasi yang dinilai sebagai suatu tantangan, luka, kehilangan, atau ancaman

N

Nyeri: adalah suatu kondisi dimana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak.

Nifas : adalah masa yang dihitung sejak seorang ibu melahirkan hingga enam minggu setelah selesai melahirkan

Neurosis : adalah gangguan yang didasari oleh unsur kecemasan atau psikologis yang lemah sehingga selalu bertingkah laku mempertahankan diri dari gangguan-gangguan dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi rasa cemas

O

Overwhelmed : adalah kondisi ketika seseorang merasa kewalahan terhadap suatu situasi.

OCD (*Obsessive Compulsive Disorder*) : adalah sebuah gangguan mental yang ditandai dengan adanya obsesi dan/ atau kompulsi.

OR : adalah Odds Ratio adalah ukuran asosiasi paparan (faktor risiko) dengan kejadian penyakit; dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko (terpapar faktor risiko) dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko (tidak terpapar faktor risiko).

Oksitosin : adalah hormon kuat yang bertindak sebagai neurotransmitter pada otak

P

Persalinan: adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang merupakan proses fisiologis terjadi pada akhir kehamilan.

Pijatan: adalah suatu aktivitas memberi tekanan pada anggota tubuh, terutama kulit, otot, dan urat, dengan teknik atau metode meremas, memutar, dan menekan lapisan otot menggunakan jari, tangan, telapat tangan, siku, dan bahkan kaki untuk menurunkan tekanan darah dan meredakan nyeri.

Primipara: adalah ibu yang melahirkan untuk pertama kalinya.

Psikososial : adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang

Psikologis : adalah kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu

Psikoterapi : adalah pelayanan psikologi yang dilakukan oleh pakar kepada pasien yang memerlukan penyembuhan diri secara psikologi. Para pakar di bidang psikoterapi adalah para psikolog dan konselor. Psikoterapi merupakan salah satu bentuk intervensi klinis.

Paritas : adalah jumlah anak yang hidup atau jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup diluar rahim.

Postpartum blues : adalah suatu sindroma gangguan afek yang ringan sering tampak dalam minggu pertama setelah

persalinan, cenderung akan memburuk pada hari ketiga sampai kelima dan berlangsung dalam rentang waktu 14 hari atau dua minggu postpartum ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas

Prevalensi : adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Psikosis : adalah kondisi ketika penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan kenyataan dan imajinasi

PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) : adalah gangguan stres pascatrauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa traumatis.

Progesterone : adalah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi dan ovulasi.

R

Relaksasi: adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan serta untuk mengelola stres

S

Sentuhan: adalah bentuk komunikasi manusia sebagai dukungan psikologis atau yang biasa disebut dengan *Magic Touch*, adalah bagian dari terapeutik yang dapat meningkatkan kondisi imun seseorang.

Sindrom : adalah kumpulan dari beberapa tanda dan gejala klinis yang sering berhubungan dan muncul bersamaan, serta diasosiasikan dengan penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Istilah sindrom dapat digunakan hanya untuk menggambarkan berbagai karakter dan gejala, bukan diagnosis

Skrining : adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang.

Sosiodemografi : adalah analisis terhadap ciri-ciri dari individu yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan pekerjaan

Skor : adalah jumlah angka

Stressor : adalah agen kimia atau biologis, kondisi lingkungan, stimulus eksternal atau peristiwa yang dianggap menyebabkan stres pada organisme. Secara psikologis, stresor dapat berupa peristiwa atau lingkungan yang mungkin dianggap menuntut, menantang, dan/atau mengancam keselamatan individu.

T

Taking in : adalah fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung dari hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan. Ibu fokus pada dirinya sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya

Taking hold : adalah fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitive sehingga mudah tersinggung

Triwulan : adalah istilah untuk sistem penanggalan yang memiliki makna tiga bulan berturut-turut

U

USAID : adalah *United States Agency for International Development* adalah badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat

V

Verbal Descriptor Scale: adalah sakala pendeskripsi verbal adalah instrument untuk mengukur beratnya nyeri yang dianggap paling bersifat objektif.

Validitas : adalah sejauh mana konsep, kesimpulan, atau pengukuran cukup beralasan dan kemungkinan sesuai secara akurat dengan dunia nyata

PROFIL PENULIS



Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T., M.Keb., seorang bidan seorang bidan kelahiran Denpasar, 9 Mei 1982 yang telah menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan tahun 2003 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Tahun 2004, penulis melanjutkan kuliah D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. Tahun 2015, penulis menyelesaikan Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Penulis juga aktif mengikuti pelatihan-

pelatihan non formal seperti Pijat Bayi, Mom and Baby SPA, Hypnobirthing dan Yoga Prenatal.

Penulis aktif sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) sejak tahun 2005. Penulis menunjukkan ketertarikan di bidang Nifas dan menyusui sejak pertama kali bergabung menjadi dosen di ITEKES Bali, hingga saat ini penulis masih dipercaya menjadi Koordinator Bidang Nifas Program Studi Kebidanan. Berbagai penelitian di bidang nifas dan menyusui telah dipublikasikan. Penulis juga telah membuat book chapter terkait nifas dan menyusui, buku referensi, Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, modul praktikum nifas, buku panduan pijat oksitosin pada ibu menyusui. Keseriusan penulis dalam melaksanakan kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi telah mengantarkan penulis menjadi dosen terbaik kedua LLDIKTI wilayah VIII tahun 2019.

Penulis berkeinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun Dosen Kebidanan serta masyarakat umum

Email Penulis: manikparwati82@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn. Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb,

Penulis adalah seorang bidan yang menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan tahun 2002 di Akademi Kebidanan Jember yang saat ini telah berubah bentuk dan tergabung dalam Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada tahun 2004, penulis melanjutkan kuliah D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2009, penulis menempuh pendidikan Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2011 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat. Penulis sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) sejak tahun 2003. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan. Hasil karya ilmiah telah terpublikasi di jurnal nasional terindeks SINTA, serta beberapa hasil cipta yang mendapatkan HaKI. Selain menjadi dosen yang melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, penulis juga aktif di organisasi IBI yaitu sebagai pengurus harian Pengrus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali, Praktik Mandiri Bidan (PMB) sejak tahun 2007, Fasilitator Pelatihan KB bagi Tenaga Dokter dan Bidan Provinsi Bali, evaluator pembukaan prodi baru serta menjadi asesor LAMPTKes. Harapan penulis semoga kedepannya dapat mencetak karya yang lebih sempurna sehingga kritik dan saran diharapkan guna peningkatan dan kualitas pada penulisan selanjutnya.

Email Penulis: ayuwulandari28@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental ibu nifas, khususnya dalam mencegah terjadinya postpartum blues. Periode pasca-melahirkan sering kali menjadi fase yang penuh tantangan, di mana ibu menghadapi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Ketidakseimbangan emosional yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi postpartum blues atau bahkan gangguan psikologis yang lebih serius.

Kehadiran keluarga, baik dari pasangan, orang tua, maupun anggota keluarga lainnya, menjadi kunci dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, dan dukungan emosional bagi ibu.

Bentuk dukungan ini dapat berupa bantuan praktis seperti membantu mengurus bayi, memberikan waktu istirahat bagi ibu, hingga pendampingan emosional yang membantu ibu merasa dihargai dan tidak sendirian. Dukungan tersebut mampu meningkatkan ketahanan emosional ibu dan membantu proses adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu.

Pendekatan keluarga yang efektif tidak hanya berfokus pada memberikan bantuan fisik tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka, menghargai perasaan ibu, dan mengidentifikasi tanda-tanda awal postpartum blues.

Dengan demikian, dukungan keluarga dapat berfungsi sebagai upaya preventif yang signifikan dalam menjaga kesehatan mental ibu dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi.

Dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental ibu nifas, khususnya dalam mencegah terjadinya postpartum blues. Periode pasca-melahirkan sering kali menjadi fase yang penuh tantangan, di mana ibu menghadapi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Ketidakseimbangan emosional yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi postpartum blues atau bahkan gangguan psikologis yang lebih serius.

Kehadiran keluarga, baik dari pasangan, orang tua, maupun anggota keluarga lainnya, menjadi kunci dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, dan dukungan emosional bagi ibu. Bentuk dukungan ini dapat berupa bantuan praktis seperti membantu mengurus bayi, memberikan waktu istirahat bagi ibu, hingga pendampingan emosional yang membantu ibu merasa dihargai dan tidak sendirian. Dukungan tersebut mampu meningkatkan ketahanan emosional ibu dan membantu proses adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu.

Pendekatan keluarga yang efektif tidak hanya berfokus pada memberikan bantuan fisik tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka, menghargai perasaan ibu, dan mengidentifikasi tanda-tanda awal postpartum blues. Dengan demikian, dukungan keluarga dapat berfungsi sebagai upaya preventif yang signifikan dalam menjaga kesehatan mental ibu dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-96-5



9

786347

097965